

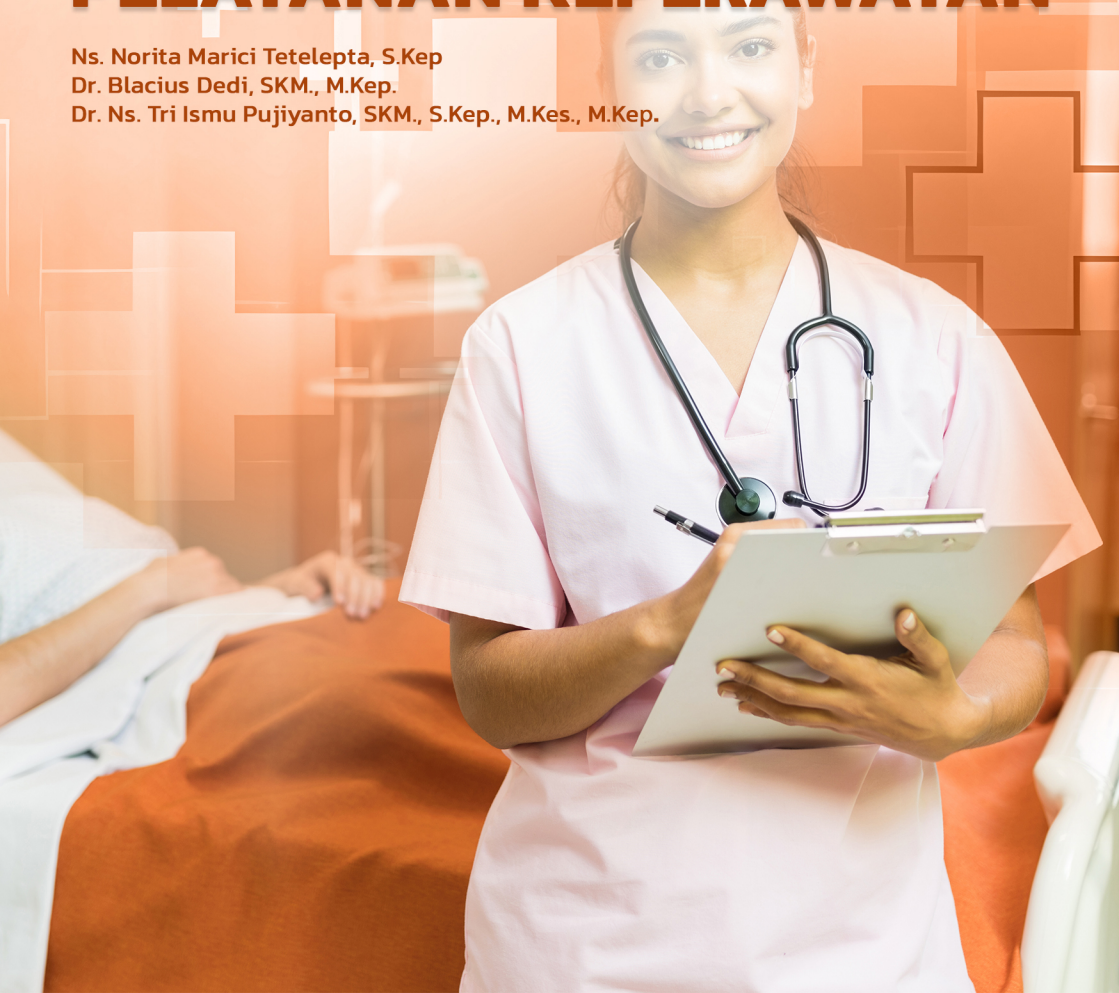
Monograf

PENGARUH PELAYANAN KEPERAWATAN BERBASIS *THEORY OF HUMAN CARING* TERHADAP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

Ns. Norita Marici Tetelepta, S.Kep

Dr. Blacius Dedi, SKM., M.Kep.

Dr. Ns. Tri Ismu Pujiyanto, SKM., S.Kep., M.Kes., M.Kep.



**BUKU MONOGRAF:
PENGARUH PELAYANAN
KEPERAWATAN BERBASIS *THEORY
OF HUMAN CARING* TERHADAP
MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN**

Penulis:

Ns. Norita Marici Tetelepta, S.Kep

Dr. Blacius Dedi, SKM., M.Kep.

Dr. Ns. Tri Ismu Pujiyanto, SKM., S.Kep., M.Kes., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

**Buku Monograf: Pengaruh Pelayanan Keperawatan Berbasis
Theory Of Human Caring Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan**

Penulis: Ns. Norita Marici Tetelepta, S.Kep.

Dr. Blacius Dedi, SKM., M.Kep.

Dr. Ns. Tri Ismu Pujiyanto, SKM., S.Kep., M.Kes., M.Kep.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN : 978-634-7294-88-3

Terbit : Agustus, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
*All Right Reserved***

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.**

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



Instagram: @bimbel.optimal

Tiktok: @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku monograf yang berjudul “*Pengaruh Pelayanan Keperawatan Berbasis Theory of Human Caring terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan*” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya ilmiah untuk mendokumentasikan dan menganalisis secara mendalam penerapan pendekatan *Theory of Human Caring* dalam praktik keperawatan serta pengaruhnya terhadap mutu pelayanan di rumah sakit, khususnya di RSUD Kabupaten Raja Ampat. Pendekatan ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, empati, kasih sayang, dan hubungan interpersonal yang bermakna antara perawat dan pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern yang semakin kompleks, penting untuk menekankan kembali esensi dari *caring* sebagai inti dari praktik keperawatan.

Pelayanan keperawatan tidak hanya sekadar memenuhi prosedur klinis, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual yang berkontribusi besar terhadap persepsi mutu pelayanan oleh pasien. Oleh karena itu, penerapan *Theory of Human Caring* menjadi landasan penting dalam membangun hubungan terapeutik dan meningkatkan kualitas layanan yang holistik dan berkesinambungan.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip *human caring* diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh tenaga keperawatan, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pelayanan yang mencakup aspek keselamatan pasien, kepuasan, dan efektivitas perawatan. Penyusunan buku ini didasarkan pada pendekatan ilmiah, hasil temuan lapangan,

serta refleksi pengalaman nyata perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien di RSUD Kabupaten Raja Ampat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi tenaga keperawatan, pengelola rumah sakit, akademisi, peneliti, serta pemangku kebijakan yang memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Secara khusus, kami menyampaikan apresiasi kepada para perawat di RSUD Kabupaten Raja Ampat yang telah berkontribusi dalam memberikan data, pengalaman, dan pandangan kritis selama proses penyusunan berlangsung. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim penulis serta seluruh pihak lain yang turut berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami dengan terbuka menerima saran dan masukan yang konstruktif dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu keperawatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam konteks pelayanan yang berpusat pada nilai kemanusiaan.

Agustus, 2025

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 KONSEP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN	5
---	----------

A. Definisi Mutu Pelayanan Keperawatan.....	5
B. Tujuan Mutu Pelayanan Keperawatan	6
C. Dimensi Mutu Pelayanan Keperawatan	10
D. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan.....	20

BAB 3 PERILAKU <i>CARING</i> MENURUT <i>THEORY OF HUMAN CARING</i>	24
---	-----------

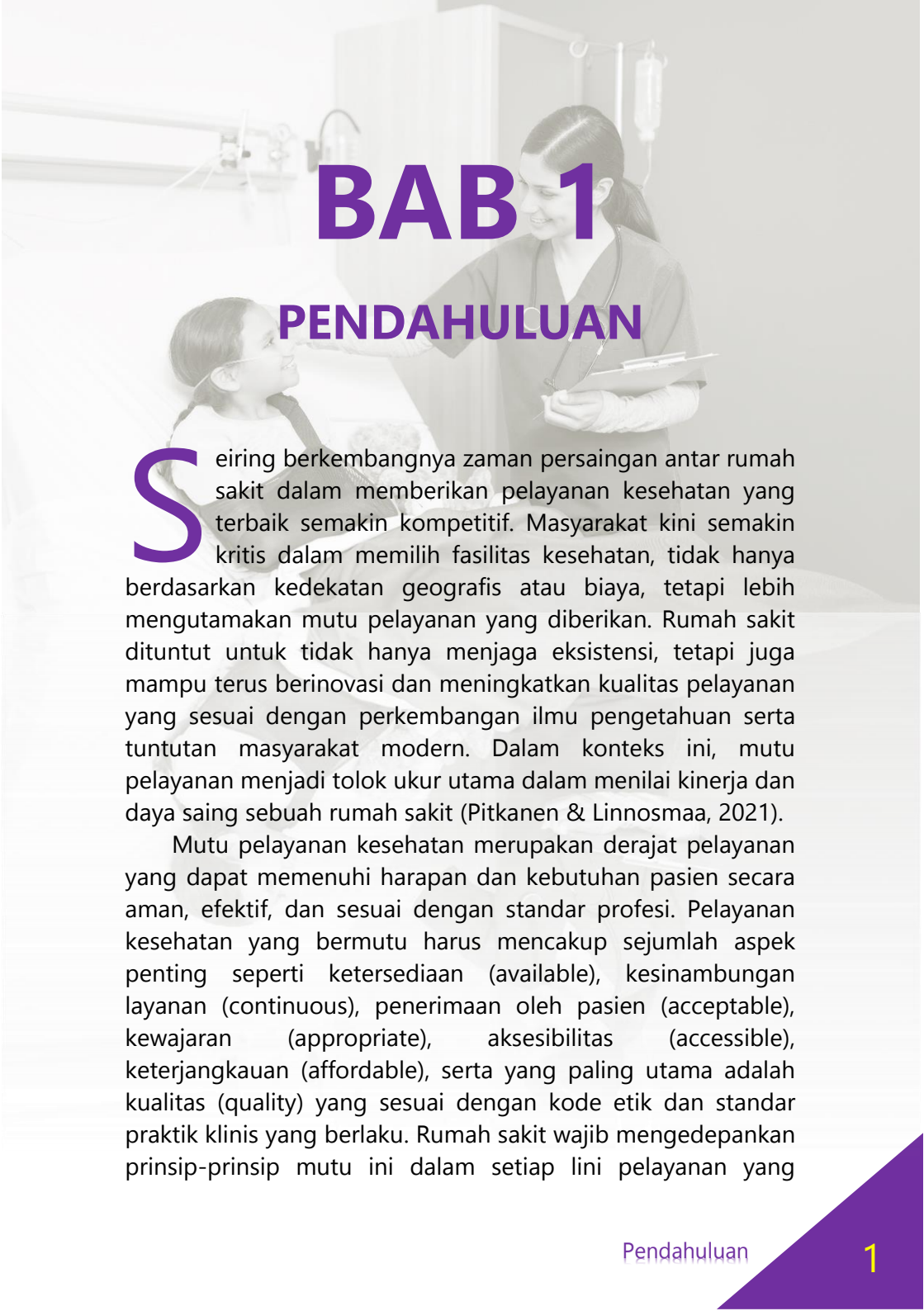
A. Perilaku <i>Caring</i> Menurut Watson	24
B. Sepuluh Faktor <i>Caritas</i> Watson	27
C. Paradigma Keperawatan Menurut Watson.....	33

BAB 4 PENGARUH PELAYANAN KEPERAWATAN BERBASIS <i>THEORY OF HUMAN CARING</i> TERHADAP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN	43
--	-----------

A. Perilaku <i>Caring</i> dalam Praktik Klinis	43
B. Pelayanan Keperawatan Berbasis <i>Theory of Human Caring</i>	47
C. Pengaruh Pelayanan Keperawatan Berbasis <i>Theory of Human Caring terhadap</i> Mutu Pelayanan Keperawatan	60

BAB 5 PENUTUP	65
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA..... 68
PROFIL PENULIS 74



BAB 1

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman persaingan antar rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik semakin kompetitif. Masyarakat kini semakin kritis dalam memilih fasilitas kesehatan, tidak hanya berdasarkan kedekatan geografis atau biaya, tetapi lebih mengutamakan mutu pelayanan yang diberikan. Rumah sakit dituntut untuk tidak hanya menjaga eksistensi, tetapi juga mampu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan masyarakat modern. Dalam konteks ini, mutu pelayanan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja dan daya saing sebuah rumah sakit (Pitkanen & Linnosmaa, 2021).

Mutu pelayanan kesehatan merupakan derajat pelayanan yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pasien secara aman, efektif, dan sesuai dengan standar profesi. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus mencakup sejumlah aspek penting seperti ketersediaan (available), kesinambungan layanan (continuous), penerimaan oleh pasien (acceptable), kewajaran (appropriate), aksesibilitas (accessible), keterjangkauan (affordable), serta yang paling utama adalah kualitas (quality) yang sesuai dengan kode etik dan standar praktik klinis yang berlaku. Rumah sakit wajib mengedepankan prinsip-prinsip mutu ini dalam setiap lini pelayanan yang

diberikan (Prapitasari & Jalilah, 2020).

Salah satu unsur krusial dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah mutu pelayanan keperawatan. Perawat sebagai tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar di rumah sakit memiliki peran sentral dalam menentukan pengalaman pasien selama menjalani perawatan. Perawat berinteraksi langsung dengan pasien selama 24 jam penuh, sehingga kualitas interaksi inilah yang banyak mempengaruhi persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan, sehingga peningkatan mutu pelayanan keperawatan merupakan investasi penting dalam menjaga citra positif rumah sakit (Baumann & Crea-Arsenio, 2023).

Pelaksanaan pelayanan keperawatan yang bermutu tidak dapat dipisahkan dari implementasi asuhan keperawatan yang profesional dan berbasis nilai-nilai humanistik. Caring menjadi komponen fundamental dalam praktik keperawatan yang berkualitas. Caring bukan hanya sekadar memberikan tindakan medis, melainkan menanamkan nilai-nilai empati, kepekaan, serta komitmen terhadap pemulihan dan kesejahteraan pasien secara holistik. Watson dalam Theory of Human Caring menekankan bahwa hubungan antara perawat dan pasien yang dilandasi oleh rasa peduli dapat menciptakan lingkungan penyembuhan yang kondusif (Alligood, 2021).

Perilaku caring perawat mencerminkan kepribadian, integritas, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Sikap seperti kesabaran, empati, kejujuran, serta kemampuan untuk hadir secara penuh (therapeutic presence) menjadi bagian penting dari caring. Tujuan dari perilaku caring bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit secara fisik, tetapi juga untuk meningkatkan martabat, harapan, serta kenyamanan emosional dan spiritual pasien. Perilaku caring juga

memperkuat hubungan antara perawat dan pasien, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit (Ghanbari, Adib, & Dianati, 2022).

Pelaksanaan perilaku caring di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Studi yang dilakukan oleh Wuwung (2020)) menunjukkan bahwa dari 90 perawat di RSUD GMIM Pancaran Kasih Manado, sebanyak 41,1% menunjukkan perilaku caring yang rendah. Temuan serupa juga didapatkan di Puskesmas Besiq Kutai Barat, di mana 44% perawat menunjukkan tingkat caring yang kurang baik (Arnike & Kadir, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gap antara idealisme teori caring dengan praktik nyata di lapangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya perilaku caring antara lain pengetahuan yang kurang memadai, motivasi kerja yang rendah, serta tingginya beban kerja.

Pengetahuan dan motivasi perawat terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku caring. Perawat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep caring cenderung lebih mampu menerapkan prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari. Beban kerja yang berlebihan, kekurangan tenaga, serta tekanan administratif yang tinggi juga dapat menghambat perawat dalam menunjukkan perhatian dan empati yang optimal. Ketika perawat mengalami kelelahan secara fisik dan emosional, maka kemampuan mereka untuk memberikan perawatan yang penuh kasih sayang akan menurun (Arsat et al., 2023).

Studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Kabupaten Raja Ampat mengungkapkan bahwa meskipun asuhan keperawatan telah dilandasi oleh prinsip ilmu keperawatan, nilai profesionalisme, dan caring, namun implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya konsisten. Masih ditemukan perawat yang belum sepenuhnya mengaplikasikan konsep caring secara

optimal yang berdampak pada rendahnya kepuasan pasien. Beberapa pasien dan keluarga bahkan menyampaikan keluhan melalui media sosial terkait sikap perawat yang kurang ramah dan kurang memberikan perhatian. Hal ini menjadi masukan berharga bagi rumah sakit untuk lebih serius dalam mengembangkan pelatihan caring dan memperkuat budaya pelayanan yang berfokus pada pasien. Perilaku caring tidak hanya akan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.



BAB 2

KONSEP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

A. Definisi Mutu Pelayanan Keperawatan

Mutu pelayanan keperawatan merupakan suatu konsep integral yang bersifat kompleks dan multidimensional serta mencerminkan sejauh mana pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi keperawatan nasional maupun internasional. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan standar prosedur, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang saling berkaitan seperti keselamatan pasien, efektivitas intervensi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kepuasan pasien terhadap layanan yang diterima. Mutu dalam pelayanan keperawatan harus dilihat sebagai hasil dari upaya sistematis yang melibatkan seluruh elemen dalam proses asuhan keperawatan mulai dari perawat pelaksana, tim manajemen keperawatan, hingga kebijakan institusi kesehatan. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga edukatif yang semuanya dilakukan dengan pendekatan profesional dan humanistik untuk menjamin tercapainya hasil perawatan yang optimal bagi

pasien (Porter, Weberg, Mangold, & Malloch, 2019).

Mutu pelayanan keperawatan juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan dan inisiatif yang dilakukan oleh tenaga keperawatan dalam upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan secara berkelanjutan. Upaya ini mencakup penerapan praktik berbasis bukti (evidence-based practice), penggunaan alat ukur mutu keperawatan, refleksi terhadap hasil kinerja, serta evaluasi rutin terhadap kepuasan dan kebutuhan pasien. Mutu pelayanan tidak hanya berorientasi pada pencapaian standar minimal, tetapi juga pada pemberian layanan yang bersifat responsif, empatik, dan proaktif, sehingga mampu menjawab tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin dinamis. Mutu pelayanan keperawatan merupakan fondasi utama dalam menjamin hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada hasil yang nyata. Konsep ini mendorong setiap perawat untuk senantiasa berinovasi dan meningkatkan kompetensi profesionalnya agar mampu memberikan pelayanan keperawatan yang tidak hanya sesuai standar, tetapi juga penuh empati, menghargai martabat pasien, dan mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual (Duffy, 2018).

B. Tujuan Mutu Pelayanan Keperawatan

Tujuan utama dari mutu pelayanan keperawatan adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang menerima layanan keperawatan memperoleh perawatan yang aman, efektif, berpusat pada pasien, tepat waktu, efisien, dan adil. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi dari pelayanan kesehatan berkualitas yang dirancang tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk meningkatkan pengalaman pasien, mempercepat proses penyembuhan,

dan mengurangi risiko yang mungkin timbul selama proses perawatan. Setiap dimensi ini berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian layanan yang unggul dan berkesinambungan. Berikut uraian lebih lanjut dari masing-masing dimensi mutu tersebut (Porter et al., 2019):

1. Keselamatan pasien

Keselamatan pasien adalah prinsip utama dalam setiap intervensi keperawatan. Keselamatan pasien berarti menghindari, mencegah, dan mengurangi kejadian yang dapat membahayakan pasien selama berada dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Perawat dituntut memiliki tingkat kewaspadaan tinggi, keterampilan klinis yang mumpuni, serta kepatuhan terhadap protokol standar keselamatan seperti *hand hygiene*, prosedur identifikasi pasien, teknik pemberian obat yang benar (*five rights*), hingga pelaksanaan pelaporan insiden keselamatan secara tepat waktu. Contoh nyata dari penerapan aspek ini antara lain: melakukan edukasi kepada pasien tentang risiko jatuh, memantau tanda-tanda vital secara berkala untuk mencegah kondisi memburuk, serta memastikan penggunaan alat medis secara steril dan sesuai prosedur. Penerapan keselamatan pasien yang konsisten, risiko cedera, infeksi nosokomial, dan kesalahan medis dapat ditekan secara signifikan.

2. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas pelayanan keperawatan ditunjukkan melalui kemampuan intervensi keperawatan dalam mencapai tujuan klinis dan kesehatan pasien berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik. Setiap tindakan keperawatan harus didasari oleh *evidence-based practice* (EBP) dan sesuai dengan panduan klinis yang berlaku agar memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien. Contoh

kasus yaitu perawat yang merawat pasien dengan luka diabetes perlu menggunakan protokol yang telah terbukti secara ilmiah mempercepat penyembuhan luka, sambil tetap menyesuaikan pendekatan dengan kondisi unik pasien tersebut. Efektivitas juga tercermin dalam keterlibatan perawat dalam pelatihan berkala, pembaruan ilmu, serta evaluasi rutin terhadap hasil asuhan yang diberikan.

3. Pelayanan yang Berpusat pada Pasien (*Patient-Centered Care*)

Pelayanan keperawatan yang bermutu tinggi harus berorientasi pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien. Hal ini berarti perawat tidak hanya memberikan intervensi medis, tetapi juga menjalin hubungan yang empatik dan humanis dengan pasien serta keluarganya. Komunikasi dua arah yang efektif, pemberdayaan pasien dalam pengambilan keputusan, dan penghormatan terhadap latar belakang budaya dan keyakinan pasien merupakan komponen penting dalam dimensi ini. Perawat sebaiknya mendiskusikan pilihan intervensi yang tersedia kepada pasien dan melibatkan mereka secara aktif dalam memilih langkah yang paling sesuai dengan nilai dan harapan mereka. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan pasien, mempercepat pemulihan, dan membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

4. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Ketepatan waktu mencerminkan kemampuan sistem pelayanan keperawatan dalam merespons kebutuhan pasien dengan segera, tanpa penundaan yang tidak perlu. Dimensi ini sangat penting terutama dalam situasi darurat atau kondisi pasien yang cepat berubah. Pelayanan yang

tidak tepat waktu dapat berakibat pada memburuknya kondisi klinis, peningkatan beban penyakit, atau bahkan kegagalan dalam menyelamatkan nyawa. Perawat dituntut untuk bersikap sigap dalam merespons alarm medis, memberikan obat sesuai jadwal, atau melakukan triase secara cepat dan akurat di ruang gawat darurat. Koordinasi yang baik antar tim serta perencanaan jadwal pelayanan juga menjadi bagian penting dalam menjamin ketepatan waktu.

5. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi dalam pelayanan keperawatan mencakup penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, sarana, dan dana) secara optimal untuk menghasilkan hasil asuhan yang maksimal. Tujuan dari efisiensi bukan sekadar memangkas biaya, melainkan memastikan bahwa semua proses keperawatan dilakukan dengan cermat, tanpa pemborosan, dan tetap menjaga mutu pelayanan. Contohnya yaitu perawat yang mampu mengelola waktu kerja dengan baik dapat menyelesaikan tindakan keperawatan prioritas dengan tepat, mengurangi waktu tunggu pasien, serta mendukung kelancaran alur pelayanan. Penggunaan alat medis yang sesuai dan pengurangan prosedur yang tidak perlu juga mencerminkan prinsip efisiensi yang baik dalam pelayanan.

6. Keadilan (*Equity*)

Keadilan atau *equity* dalam pelayanan keperawatan memastikan bahwa semua pasien, tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, usia, jenis kelamin, agama, budaya, atau kondisi disabilitas, memperoleh akses yang sama terhadap layanan keperawatan yang berkualitas. Dimensi ini menegaskan

bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian layanan. Perawat dituntut untuk menunjukkan sikap profesional, menghormati keberagaman, serta bersikap inklusif dalam setiap aspek pelayanan. Praktik keperawatan yang berkeadilan juga mencakup pemberian edukasi kesehatan yang mudah dipahami oleh pasien dari berbagai latar belakang, serta memastikan bahwa kelompok rentan tetap mendapatkan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan mereka.

C. Dimensi Mutu Pelayanan Keperawatan

Dimensi mutu pelayanan keperawatan terbagi menjadi lima dimensi yaitu:

1. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap (*responsiveness*) mengacu pada kemampuan petugas pelayanan, termasuk perawat, dalam memberikan respon yang cepat, tepat, dan empatik terhadap kebutuhan serta harapan pasien. Dalam konteks ini, setiap petugas dituntut untuk memahami bahwa pelayanan yang diberikan sangat memengaruhi persepsi dan perilaku penerima layanan. Kemampuan untuk menjelaskan secara bijak, rinci, mendidik, serta mengarahkan pasien agar mereka dapat memahami prosedur dan mekanisme pelayanan yang berlaku dalam suatu institusi.

Responsivitas menjadi penting terutama saat pasien menghadapi prosedur yang baru pertama kali mereka alami. Ketika pasien merasa bingung atau tidak memahami persyaratan pelayanan, petugas seharusnya memberikan penjelasan yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kebingungan. Penjelasan ini harus mampu membantu pasien merasa dimengerti dan dipandu melalui proses pelayanan tanpa merasa

terbebani. Hal ini mencerminkan ketanggapan pemberi layanan dalam menciptakan pelayanan yang lancar, cepat, dan mudah diakses.

Organisasi pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan, menyadari pentingnya kualitas layanan yang responsif. Pelayanan dianggap berhasil bila petugas mampu memberikan penjelasan yang bersifat edukatif dan persuasif, sehingga pasien merasa paham serta mampu merespons pelayanan dengan baik. Kualitas daya tanggap ini bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Penjelasan yang bijaksana, yaitu menyampaikan informasi pelayanan dengan cara yang menghormati dan menenangkan, sehingga pasien dapat memahami dan menerima layanan yang diberikan.
- b. Penjelasan yang mendetail, berupa uraian yang jelas, ringkas, transparan, dan relevan dengan situasi yang dihadapi pasien.
- c. Pembinaan, yaitu memberikan arahan atau bimbingan jika pasien belum memahami atau mengikuti prosedur dengan benar.
- d. Pengarahan, yaitu mengarahkan pasien agar dapat menyiapkan dan mengikuti ketentuan layanan dengan tepat.
- e. Pendekatan persuasif, yaitu membujuk pasien dengan pendekatan yang ramah dan profesional saat ada kendala atau ketidaksesuaian dalam pelayanan.

Penerapan prinsip-prinsip di atas membuat kualitas daya tanggap dapat menjadi cerminan dari profesionalisme dan keberhasilan kinerja petugas dalam memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu. Responsivitas bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kemampuan membangun hubungan

komunikasi yang efektif dan saling memahami antara pemberi dan penerima layanan.

2. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan (*assurance*) merupakan dimensi penting yang menekankan pada kepastian dan kepercayaan yang dirasakan oleh pasien atau penerima layanan terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Jaminan ini mencakup rasa aman, keyakinan, dan kepercayaan bahwa proses pelayanan akan berjalan secara profesional, tepat, dan memuaskan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Jaminan berarti adanya kepastian terhadap kelengkapan dan keberhasilan suatu pelayanan yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan. Kepastian ini menyangkut ketepatan waktu, kecepatan respons, kemudahan prosedur, kelancaran proses, serta mutu atau kualitas layanan yang menyeluruh. Ketika pasien merasa yakin bahwa pelayanan diberikan secara tuntas dan profesional, maka hal ini akan meningkatkan kepuasan serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi pelayanan kesehatan tersebut.

Kualitas jaminan pelayanan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting:

a. Kinerja profesional perawat

Tingkat keandalan, kemandirian, dan profesionalisme perawat sangat menentukan apakah pasien merasa aman dan yakin terhadap pelayanan yang diterima. Perawat yang menunjukkan pengetahuan, keterampilan klinis yang mumpuni, serta kemampuan komunikasi interpersonal yang baik akan memberikan rasa percaya diri bagi pasien dalam proses perawatan.

b. Komitmen organisasi terhadap mutu pelayanan

Organisasi kesehatan yang memiliki budaya mutu

yang kuat akan mendorong seluruh tenaga kesehatannya untuk bekerja dengan serius, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan internal, pelatihan berkala, serta pemantauan mutu secara sistematis.

- c. Perilaku dan sikap kepribadian tenaga kesehatan
Sikap ramah, empati, sopan santun, dan etika dalam berinteraksi dengan pasien menjadi bagian dari dimensi jaminan. Seseorang yang menerima pelayanan tidak hanya menilai dari sisi teknis, tetapi juga dari cara perawat memperlakukan mereka secara manusiawi dan bermartabat. Sebaliknya, tenaga kesehatan yang bersikap kasar, acuh, atau tidak komunikatif akan mengurangi persepsi jaminan dari sisi pasien.
- d. Kesesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP)

Jaminan pelayanan juga ditentukan oleh sejauh mana prosedur dilaksanakan sesuai dengan standar. Pelayanan yang konsisten dengan SOP memperlihatkan keprofesionalan dan menjamin keamanan serta efektivitas tindakan keperawatan.

Tiga pilar utama dari jaminan pelayanan keperawatan dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Kepuasan pelayanan: Pasien merasakan bahwa layanan diberikan secara cepat, akurat, mudah diakses, dan memenuhi ekspektasi mereka. Ini menjadi bukti nyata keberhasilan pelayanan yang memuaskan.
- b. Komitmen kerja: Tenaga kesehatan menunjukkan integritas, etos kerja tinggi, dan konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi

organisasi.

- c. Perilaku meyakinkan: Sikap dan perilaku petugas yang positif, tenang, kompeten, serta dapat dipercaya membangun persepsi bahwa pelayanan tersebut aman dan berkualitas.

Pengimplementasian jaminan pelayanan yang baik memungkinkan rumah sakit atau institusi kesehatan dapat membangun citra positif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pasien, serta mencapai keberhasilan dalam mutu pelayanan secara menyeluruh. Pelayanan yang meyakinkan bukan hanya memberikan rasa aman kepada pasien, tetapi juga mencerminkan prestasi kerja tenaga kesehatan dan keberhasilan manajerial organisasi dalam mengelola pelayanan keperawatan yang unggul.

3. Daya Tanggap (*Tangible*)

Bukti fisik (*tangible*) merujuk pada semua elemen pelayanan yang dapat diamati secara nyata, seperti fasilitas, peralatan, dan tampilan visual dari pemberi pelayanan. Dimensi ini memainkan peran penting dalam membentuk persepsi pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan. Bukti fisik menjadi indikator yang pertama kali dilihat dan dirasakan oleh pasien, sehingga dapat menciptakan kesan awal yang kuat tentang profesionalisme dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh institusi pelayanan kesehatan.

Bukti fisik mencakup beragam aspek mulai dari kebersihan dan kerapian lingkungan rumah sakit atau ruang rawat, ketersediaan dan kecanggihan peralatan medis, hingga penampilan perawat itu sendiri termasuk seragam, etika penampilan, serta cara berinteraksi dengan pasien. Ketika pasien melihat lingkungan yang bersih, tertata, dan didukung oleh peralatan yang modern

dan fungsional, mereka cenderung merasa lebih aman dan yakin akan mutu asuhan keperawatan yang akan mereka terima.

Bentuk fisik pelayanan berkontribusi terhadap persepsi masyarakat terhadap profesionalisme tenaga kesehatan. Pelayanan yang dibungkus dengan sarana yang baik akan menambah nilai persepsi mutu layanan. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan pelayanan tidak hanya terletak pada kompetensi teknis perawat, tetapi juga pada bagaimana pelayanan tersebut dikemas dan disampaikan secara visual serta fungsional. Bukti fisik adalah perwujudan dari prestasi kerja tenaga kesehatan, yang dapat dievaluasi melalui penggunaan efektif fasilitas, penguasaan teknologi, dan ketepatan dalam memanfaatkan alat-alat kesehatan dalam memberikan layanan kepada pasien. Penilaian terhadap dimensi ini juga dapat dilihat dari kesiapan sistem informasi, kenyamanan ruang pelayanan, serta kemampuan perawat dalam mengadaptasi teknologi terbaru sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas.

Kualitas pelayanan yang ditampilkan secara fisik turut menciptakan citra positif bagi institusi pelayanan kesehatan. Kondisi fisik yang mendukung akan membentuk kepercayaan pasien serta meningkatkan reputasi organisasi di mata masyarakat. Lebih dari itu, integritas dan dedikasi perawat juga ditampilkan melalui penampilan profesional dan sikap kerja yang baik dalam memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang tersedia. Bukti fisik bukan hanya sekadar perlengkapan, tetapi juga representasi dari sistem kerja yang efisien dan berkinerja tinggi. Identifikasi kualitas layanan dari aspek fisik mencakup:

- a. Kemampuan menggunakan alat dan perlengkapan kerja secara efektif dan efisien, menunjukkan bahwa pelayanan dilakukan dengan kompetensi teknis yang baik.
- b. Penguasaan terhadap teknologi pelayanan, termasuk sistem informasi dan otomasi yang mendukung dokumentasi serta pelaporan pelayanan secara cepat dan akurat.
- c. Penampilan personal dan integritas profesional, yang mencerminkan dedikasi serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.

Dimensi bukti fisik dalam mutu pelayanan keperawatan tidak hanya menjadi simbol keberadaan pelayanan, tetapi juga mencerminkan kesiapan organisasi dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional. Lingkungan fisik yang memadai, teknologi yang dikelola dengan baik, serta penampilan tenaga keperawatan yang kredibel adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan pasien serta meningkatkan kualitas pengalaman pelayanan secara keseluruhan.

4. Empati (*Empathy*)

Empati merupakan salah satu elemen kunci dalam pelayanan keperawatan yang bermutu. Dimensi ini menekankan pentingnya perhatian mendalam, kepedulian tulus, dan kemampuan untuk memahami kondisi emosional serta kebutuhan pasien secara menyeluruh. Empati dalam konteks pelayanan berarti bahwa perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus memiliki kepekaan terhadap perasaan, harapan, serta kekhawatiran pasien dan keluarganya. Empati bukan hanya sekadar sikap simpatik, melainkan keterlibatan emosional dan intelektual dalam memahami situasi orang

lain untuk memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan holistik.

Pelayanan yang dilandasi oleh empati akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemberi dan penerima layanan. Ketika perawat mampu menempatkan diri pada posisi pasien, maka keputusan dan tindakan yang diambil akan lebih tepat sasaran, tidak hanya dari sisi klinis tetapi juga dari segi kenyamanan dan kepuasan pasien. Hal ini menciptakan suasana yang saling percaya, mendukung, serta memperkuat komunikasi terapeutik antara pasien dan perawat.

Empati dalam praktik keperawatan juga mencerminkan pemahaman atas keterbatasan dan kondisi kedua belah pihak, dimana perawat perlu memahami kondisi pasien, pasien dan keluarganya juga perlu diedukasi agar memahami peran, kapasitas, dan batasan petugas kesehatan. Keseimbangan ini akan mendukung terciptanya pelayanan yang sinergis dan saling menghargai. Empati dalam pelayanan keperawatan dapat diwujudkan melalui beberapa indikator berikut:

a. Perhatian Individual (Personalized Attention)

Perawat memberikan perhatian khusus dan personal kepada setiap pasien, memperlakukan mereka bukan sekadar sebagai objek perawatan, tetapi sebagai individu dengan latar belakang dan kebutuhan unik. Hal ini membuat pasien merasa dihargai dan diperhatikan secara utuh.

b. Keseriusan dalam Memberikan Pelayanan

Tindakan dan respon perawat yang serius dan profesional dalam menghadapi keluhan dan kebutuhan pasien akan menimbulkan rasa aman dan

percaya dari pihak pasien. Kesungguhan dalam memberikan pelayanan mencerminkan integritas dan dedikasi perawat terhadap tugasnya.

c. Sikap Simpatik dan Ramah

Sikap simpati secara verbal maupun nonverbal seperti melalui nada bicara, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh dapat membantu menenangkan pasien, terlebih dalam situasi kritis atau penuh kecemasan.

d. Kemampuan Memahami dan Mendengarkan Aktif

Perawat perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami apa yang dirasakan atau dikatakan pasien. Ini dapat dilakukan melalui teknik komunikasi terapeutik seperti paraphrasing, clarifying, dan reflecting, yang mencerminkan kepedulian dan kesungguhan dalam mendengar.

e. Keterlibatan Emosional yang Positif

Empati juga ditunjukkan melalui keterlibatan perawat dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi pasien. Hal ini termasuk kesiapan memberikan bantuan emosional maupun informasi yang dapat meringankan beban psikologis pasien.

Empati menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan. Pelayanan yang dilandasi empati tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian hasil klinis yang lebih baik. Empati merupakan cerminan dari prestasi kerja yang tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga didukung oleh kecerdasan emosional dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan

keperawatan.

5. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan merupakan salah satu dimensi penting dalam mutu pelayanan keperawatan yang menekankan pada konsistensi dan kemampuan tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan secara tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Keandalan dalam konteks pelayanan keperawatan berarti perawat harus memiliki kapasitas dan kompetensi profesional yang tinggi, baik dalam hal pengetahuan teoretis, keterampilan teknis, maupun sikap kerja yang profesional. Hal ini memungkinkan setiap tindakan keperawatan yang dilakukan dapat menghasilkan pelayanan yang memuaskan, tepat waktu, serta minim kesalahan atau keluhan dari pasien maupun keluarga pasien.

Seorang perawat yang andal diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan efisien, memahami dan menerapkan prosedur standar operasional (SOP) dengan baik, serta mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pelayanan. Keandalan tidak hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari konsistensi dalam memberikan pelayanan berkualitas, keterampilan dalam menggunakan alat atau teknologi keperawatan, serta kecepatan dan ketepatan dalam merespon kebutuhan pasien.

Keandalan dalam pelayanan juga meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang telah disampaikan, dimana perawat harus bisa menjaga kepercayaan pasien dengan memberikan pelayanan yang sesuai ekspektasi, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan kapan pun dibutuhkan. Lingkungan

rumah sakit yang dinamis dan kompleks menjadikan keandalan sebagai salah satu indikator kunci dalam menilai profesionalisme tenaga keperawatan. Pegawai yang memiliki keandalan tinggi biasanya mampu menampilkan:

- a. Pengetahuan yang mendalam dan terkini mengenai tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kebijakan, prosedur, serta praktik terbaik dalam pelayanan keperawatan.
- b. Keterampilan teknis yang terlatih dan terasah, yang memungkinkan pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan efektif.
- c. Pengalaman kerja yang relevan, yang membuat perawat mampu mengambil keputusan klinis secara tepat berdasarkan kasus yang dihadapi.
- d. Kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi keperawatan, termasuk pemanfaatan peralatan medis, sistem informasi keperawatan, serta dokumentasi digital yang menunjang pelayanan berkualitas tinggi.

Keandalan tenaga keperawatan tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis individu, tetapi juga mencerminkan sistem kerja yang profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien. Seorang perawat yang andal adalah mereka yang mampu menjawab tantangan pelayanan keperawatan secara proaktif, solutif, dan konsisten dalam memberikan pelayanan berkualitas secara terus menerus.

D. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

Peningkatan mutu pelayanan keperawatan merupakan komitmen berkelanjutan yang harus dilakukan oleh setiap institusi pelayanan kesehatan. Berbagai pendekatan dan strategi dapat diimplementasikan untuk menjamin bahwa

pelayanan keperawatan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga berkontribusi terhadap keselamatan dan kepuasan pasien. Berikut ini beberapa strategi utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan:

1. Pengembangan sistem akreditasi rumah sakit

Akreditasi merupakan mekanisme evaluasi mutu yang sangat penting. Akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Proses akreditasi mendorong rumah sakit untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta peningkatan sistem manajemen mutu yang transparan dan terukur.

2. Penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menekankan pada pendekatan proses dan kepuasan pelanggan. Implementasi ISO memastikan bahwa setiap proses pelayanan keperawatan berjalan konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan pasien. Hal ini menciptakan budaya mutu yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan peningkatan efisiensi operasional.

3. Pemutakhiran pengetahuan dan kompetensi tenaga kesehatan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan menuntut tenaga keperawatan untuk terus

memperbarui keilmuannya. Peningkatan mutu pelayanan keperawatan harus didasarkan pada evidence-based practice yaitu praktik keperawatan yang berlandaskan pada hasil-hasil penelitian terbaru dan pedoman klinis yang terbukti efektif. Pelatihan berkala, seminar ilmiah, dan pendidikan berkelanjutan menjadi cara utama untuk menjamin kompetensi dan profesionalisme perawat tetap relevan dan mutakhir.

4. Penerapan good corporate governance (GCG)

Good corporate governance mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penerapan GCG dalam organisasi pelayanan kesehatan bertujuan untuk menciptakan tata kelola institusi yang efisien dan berorientasi pada mutu pelayanan. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang etis, pengelolaan sumber daya secara profesional, serta pengawasan internal yang ketat terhadap proses pelayanan.

5. Implementasi clinical governance

Clinical governance merupakan bagian integral dari good corporate governance yang secara khusus berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan klinis. Rumah sakit menciptakan sistem yang mendukung profesional kesehatan untuk memberikan pelayanan dengan standar tinggi dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran dan akuntabilitas. Clinical governance mencakup audit klinis, pelaporan insiden keselamatan pasien, supervisi klinis, pengembangan kebijakan klinis, serta evaluasi hasil pelayanan keperawatan.

6. Aliansi strategis antar rumah sakit dan institusi kesehatan
Era globalisasi dan keterbukaan informasi penting

untuk membangun kolaborasi dengan rumah sakit lain, baik di dalam maupun luar negeri menjadi strategi terbaik dalam peningkatan mutu. Aliansi strategis dapat mencakup pertukaran pengetahuan, benchmarking pelayanan, pelatihan bersama, serta pengembangan sistem rujukan yang lebih efektif. Kolaborasi lintas sektor dan lintas fungsi juga diperlukan untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Budaya kerja sama ini perlu ditanamkan sebagai bagian dari nilai inti organisasi.

7. Evaluasi strategi pembiayaan rumah sakit

Biaya pelayanan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan rumah sakit. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembiayaan perlu dilakukan untuk menjamin efisiensi dan keberlanjutan operasional. Pendekatan seperti outsourcing untuk layanan non-medis (misalnya kebersihan, gizi, laundry, dan parkir), contracting out, serta eksplorasi model pembiayaan alternatif dapat membantu menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan.



BAB 3

PERILAKU *CARING* MENURUT *THEORY OF HUMAN CARING*

A. Perilaku *Caring* Menurut Watson

Watson's Theory of Human Caring merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam ilmu keperawatan modern. Jean Watson memandang *caring* bukan hanya sebagai tindakan atau prosedur teknis keperawatan, melainkan sebagai inti dari praktik keperawatan itu sendiri yang berakar pada hubungan manusiawi dan nilai-nilai kemanusiaan. *Caring* bukan sekadar pendekatan klinis, tetapi sebuah proses transpersonal yang melibatkan interaksi mendalam antara perawat dan pasien dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, mencegah penderitaan, serta memfasilitasi penyembuhan dalam arti yang holistik.

Watson mendefinisikan *caring* sebagai hubungan transaksional antara perawat sebagai pemberi asuhan dan klien sebagai penerima asuhan, yang dilandasi oleh rasa hormat, kehadiran penuh kesadaran (*mindfulness*), serta komitmen untuk menjaga dan memelihara martabat serta potensi penyembuhan pasien. Watson menyusun tujuh asumsi dasar *caring* yang menjadi kerangka filosofis dan praktis dalam pelaksanaan keperawatan berbasis *caring*,

antara lain:

1. Caring dapat dilakukan dan dipraktikkan secara interpersonal

Caring tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia melibatkan interaksi yang saling memengaruhi antara dua individu: perawat dan pasien. Proses ini bersifat transpersonal, yakni melampaui dimensi fisik dan teknis untuk menjangkau aspek emosional, spiritual, dan eksistensial dari pasien. Perawat hadir secara utuh sebagai manusia yang menyapa kemanusiaan pasien, bukan sekadar memenuhi tugas administratif atau prosedural.

2. Caring meliputi faktor-faktor karatif yang dihasilkan dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia

Caring dalam keperawatan harus berlandaskan *carative factors*, yaitu nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kasih sayang, rasa hormat, dan perhatian tulus terhadap kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Faktor-faktor ini menekankan pentingnya melihat pasien sebagai pribadi utuh yang memiliki kebutuhan kompleks, bukan hanya sebagai objek penderita penyakit.

3. Caring yang efektif akan meningkatkan status kesehatan dan perkembangan individu maupun keluarga

Perawat yang menunjukkan sikap caring yang tulus maka dampaknya bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang dapat mempercepat proses penyembuhan, menurunkan tingkat kecemasan pasien, dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan keluarga terhadap layanan keperawatan.

4. Respon caring adalah menerima seseorang tidak hanya berdasarkan kondisi saat ini tetapi seperti apa dia mungkin akan menjadi di masa depan

Perawat yang caring tidak hanya melihat pasien sebagai seseorang yang sakit, tetapi sebagai pribadi yang memiliki potensi untuk sembuh, berkembang, dan menjalani kehidupan bermakna. Ini mencerminkan pandangan optimis dan humanistik dalam praktik keperawatan, di mana perawat mendampingi pasien dalam perjalanan pemulihan jangka panjang.

5. Caring environment menyediakan perkembangan potensi dan memberi keleluasaan dalam memilih kegiatan terbaik bagi dirinya

Lingkungan yang *caring* harus memberikan rasa aman, penghargaan terhadap pilihan individu, serta mendukung tumbuhnya kepercayaan diri pasien. Lingkungan ini memungkinkan pasien mengeksplorasi cara-cara yang bermakna untuk mendukung penyembuhannya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan secara sadar dan partisipatif.

6. Caring bersifat *healthogenic* dari pada sekadar *curing*

Caring tidak hanya berfokus pada penyembuhan medis (*curing*), tetapi juga pada penciptaan kondisi yang mendukung kesehatan secara menyeluruh (*healthogenic*). Ini mencakup aspek psikososial, spiritual, dan emosional pasien yang mungkin tidak selalu diperhatikan dalam praktik keperawatan yang hanya menitikberatkan pada intervensi klinis. Caring di sini menjadi pendekatan holistik yang memadukan ilmu pengetahuan dan seni dalam keperawatan.

7. Caring merupakan inti dari keperawatan

Watson menegaskan bahwa caring bukan sekadar atribut tambahan, tetapi merupakan esensi dari profesi keperawatan. Caring menjadi landasan moral dan filosofis yang menjiwai semua tindakan keperawatan. Hal ini

tercermin dalam *Ten Caritas Processes* yaitu sepuluh proses spiritual dan emosional yang menjadi bahasa universal dalam praktik caring dan dapat digunakan oleh perawat dalam setiap interaksi dengan pasien.

B. Sepuluh Faktor Caritas Watson

Proses caritas Watson memberi perawat seperangkat prinsip dan bahasa panduan untuk menciptakan dan terlibat dalam suatu hubungan caring dengan pasien. Proses caritas ini harus dilakukan bersamaan dengan pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan klinis yang harus dimiliki setiap perawat dalam melakukan praktik profesionalnya. Watson menguraikan setiap proses caritas dengan menggambarkan fokusnya pada nilai-nilai sebagai berikut (Alligood, 2021):

1. Membentuk sistem nilai humanistic altruistic

Nilai humanistik dan altruistik dipelajari sejak dini, tetapi dapat dipengaruhi oleh pengalaman klinis perawat. Proses ini dapat didefinisikan sebagai kepuasan melalui pemberian diri dan peningkatan pemahaman tentang cinta dan rasa peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Humanistik-altruistik sebagai dasar kepedulian dimana perawat memberikan perawatan profesional dengan demikian, merupakan faktor pertama dan paling dasar untuk ilmu pengetahuan dan etika kepedulian (Watson, 2007).

Altruisme merupakan salah satu aspek dari nilai caring yang mencakup dua kategori utama "kepedulian humanistik" dan "sikap peduli". Seorang perawat menunjukkan sikap humanistik altruistik dengan berempati kepada pasien yang dirawat dan keluarga pasien. Altruisme sebagai bentuk perhatian perawat terhadap kesejahteraan pasien dalam kapasitas profesional mereka. Altruisme digambarkan sebagai

keterlibatan dalam tindakan peduli terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Perilaku altruistik dimotivasi oleh kepedulian terhadap orang lain atau oleh nilai-nilai, tujuan, dan penghargaan diri yang terinternalisasi daripada harapan untuk memperoleh imbalan.

Manifestasi caring perawat berdasarkan pengertian humanistik altruistik adalah mengenali nama pasien, memanggil nama pasien sesuai dengan yang disenangi pasien dan mengenali kelebihan dan karakteristik lain dari pasien, mendahulukan kepentingan pasien, menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien, melibatkan pasien dalam membuat keputusan dan menghargai keputusan pasien terkait keperawatan yang diterimanya dan meningkatkan status kesehatan pasien serta menggunakan sentuhan yang menyembuhkan. Perilaku ini dilakukan perawat pada saat pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Putri, 2014).

2. Membangkitkan keyakinan – harapan.

Perawat mendorong keyakinan pasien dan menghormatinya sebagai pengaruh yang signifikan dalam mempromosikan dan menjaga kesehatan. Seorang perawat harus memelihara iman, harapan dan sistem kepercayaan yang mendalam, bahkan ketika tidak ada harapan untuk dilakukan secara medis, perawat harus memelihara iman dan harapan pasien yang melampaui kemampuan manusia (Alligood, 2021).

Manifestasi perilaku caring perawat adalah memberikan motivasi kepada pasien untuk menerima penyakit yang dideritanya sekalipun penyakit terminal, mendorong pasien untuk menerima dan menjalani upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan, memberi

motivasi dan mengarahkan pasien untuk mencari alternatif terapi secara rasional, memberi penguatan kepada pasien bahwa setiap orang memiliki takdirnya masing-masing dan memberi keyakinan bahwa kehidupan dan kematian adalah hak Tuhan yang dapat kita lakukan adalah berupaya untuk melakukan yang terbaik (Akansel, Watson, Vatansever, & Özdemir, 2021).

3. Menanamkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain.

Pengenalan perasaan mengarah pada aktualisasi diri melalui penerimaan diri baik bagi perawat maupun pasien. Orang yang tidak peka dan menekan perasaannya sendiri tidak diizinkan orang lain untuk mengeksplorasi perasaan mereka. Kepekaan terhadap diri sendiri tidak hanya mengarah pada penerimaan diri dan pertumbuhan psikologis, tetapi untuk kepekaan dan penerimaan terhadap orang lain. Perawat yang peka terhadap orang lain lebih dapat menerima pandangan orang lain dan mampu meningkatkan kepedulian terhadap orang lain dengan memberikan kenyamanan, pemulihan, dan kesejahteraan. Perawat yang mengenali dan menggunakan perasaan mereka dapat mempromosikan pengembangan diri dan aktualisasi diri, serta mampu mendorong pertumbuhan yang sama pada orang lain (Alligood, 2021).

4. Mengembangkan hubungan saling percaya dan saling membantu.

Proses ini mengingatkan perawat bahwa hubungan perawat-pasien dibangun di atas otentisitas kehadiran manusia. Ini adalah proses menjadi lebih sadar bahwa panggilan kita sebagai manusia di dunia dan lingkungan rumah sakit adalah panggilan untuk saling berbagi dan

membantu. Perawat yang mampu menerapkan ketrampilan keperawatan dasar ini dalam praktik sehari-hari mampu menciptakan kemampuan untuk menghasilkan kepercayaan dan memberikan perawatan yang dibutuhkan. Hubungan saling membantu dan saling percaya ini membutuhkan komitmen dari perawat meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan pasien dan keluarga, hadir dan mendengarkan keluhan pasien (Breneol, Goldberg, & Watson, 2019).

Pengembangan hubungan saling membantu-percaya antara perawat dan pasien sangat penting untuk perawatan transpersonal. Hubungan saling percaya mampu menerima dan menghargai ekspresi perasaan baik positif maupun negatif dari pasien. Hubungan ini menyangkut tiga hal yaitu:

- a. Kecocokan yang meliputi kesesuaian dengan kenyataan, kejujuran, ketulusan (tidak menerima imbalan) dan nyata.
 - b. *Non Posesive warmth* ditunjukkan melalui bicara volume suara yang rendah, rileks, sikap terbuka dan ekspresi wajah yang sesuai dengan komunikasi dengan orang lain.
 - c. Komunikasi efektif berhubungan dengan pasien (Alligood, 2021).
5. Meningkatkan dan menerima sebuah ekspresi, baik perasaan positif dan perasaan negatif.

Berbagi perasaan adalah resiko yang harus diambil perawat dan pasien. Perawat harus siap menghadapi perasaan positif dan negatif pasien. Perawat harus memahami bahwa pemahaman intelektual dan emosional terhadap suatu situasi berbeda-beda. Manifestasi perilaku caring perawat adalah menjadi

pendengar yang aktif dengan mendengarkan keluhan pasien secara sabar, mendengarkan ekspresi perasaan pasien tentang keinginannya untuk sembuh dan apa yang akan dilakukan jika sembuh, memotivasi pasien untuk mengungkapkan perasaannya baik positif maupun negatif sebagai bagian dari kekuatan yang dimilikinya serta menjelaskan tentang pemahaman diri perawat terhadap penderitaan pasien (Breneol et al., 2019).

6. Menggunakan metode sistematis untuk memecahkan sebuah masalah dan metode untuk pengambilan keputusan.

Proses keperawatan dari pengkajian–intervensi–implementasi–evaluasi merupakan sebuah sistem yang sistematis. Penggunaan proses keperawatan dalam asuhan keperawatan akan menuntun perawat dalam memecahkan masalah pasien dengan pendekatan keperawatan yang berorientasi pada kesembuhan pasien. Manifestasi perilaku caring perawat adalah selalu mengkaji, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi asuhan keperawatan sesuai dengan masalah pasien, dengan melibatkan pasien dalam membuat keputusan tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan (Breneol et al., 2019).

7. Meningkatkan proses pembelajaran dalam hubungan interpersonal.

Faktor ini sangat penting untuk perawat dalam menerapkan prinsip caring. Perawat memfasilitasi proses ini dengan memberikan pembelajaran kepada pasien untuk melakukan perawatan secara mandiri, menentukan kebersihan diri dan memberikan peluang untuk pertumbuhan diri mereka.

Manifestasi perilaku caring perawat adalah

menjelaskan setiap keluhan pasien secara rasional dan ilmiah sesuai dengan tingkat penalaran pasien dan cara mengatasinya, selalu menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, menunjukkan situasi yang bermanfaat agar pasien memahami proses penyakitnya, mengajukan cara pemenuhan kebutuhan sesuai masalah yang dihadapi pasien, menanyakan kepada pasien tentang kebutuhan pengetahuan yang ingin diketahui terkait dengan penyakitnya dan meyakinkan pasien tentang kesediaan perawat untuk menjelaskan apa yang ingin diketahui (Smith, Turkel, Wolf, & Watson Caring Science Institute, 2013).

8. Menyediakan lingkungan psikologis, fisik, sosial budaya, dan spiritual, yang mendukung, melindungi dan memperbaiki.

Perawat harus mengenali tentang pengaruh baik internal atau eksternal yang mempengaruhi kondisi kesehatan pasien, konsep yang relevan dengan lingkungan internal meliputi kesehatan mental dan spiritual serta kepercayaan terkait sosiokultural. Lingkungan eksternal meliputi: kenyamanan, keamanan, privasi, kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar.

Manifestasi perilaku caring perawat adalah menyetujui keinginan pasien dengan pemuka agama, memfasilitasi kebutuhan pasien untuk berdoa, bersedia menghubungi keluarga atau teman pasien atas permintaan pasien. Perilaku caring ini dapat dilakukan perawat pada saat pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi asuhan keperawatan (Duffy, 2018).

9. Membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Perawat mengenali kebutuhan bio-psiko-fisik dan interpersonal dari setiap pasien. Kebutuhan paling rendah

pasien adalah kebutuhan biofisikal misalnya makan, minum, eliminasi, ventilasi. Kebutuhan lebih tinggi adalah psikososial misalnya kemampuan beraktivitas dan seksual. Kebutuhan paling tinggi adalah aktualisasi diri. Hal ini sesuai dengan teori caring, bahwa caring menjamin adanya kepuasan terhadap kepuasan manusia.

Manifestasi perilaku caring perawat adalah selalu bersedia memenuhi dasar dengan selalu menyatakan bangga dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi pasien dan mampu menghargai pasien dan privasi pasien ketika sedang memenuhi kebutuhannya dan mampu menunjukkan kepada pasien bahwa pasien adalah orang yang pantas dihormati dan dihargai (Duffy, 2018).

10. Mengijinkan kekuatan eksistensial–fenomenologis.

Menurut Watson, faktor ini menjadi faktor yang sulit dimengerti, tetapi faktor ini termasuk dalam faktor yang turut menyediakan sebuah pengalaman yang menuntun kepada pengertian yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain (Alligood, 2021). Manifestasi perilaku caring adalah memberi kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk melakukan ritual sesuai dengan keyakinan pasien demi proses penyembuhannya, memfasilitasi pasien dan keluarga untuk melakukan terapi alternatif sesuai keinginannya, mampu memotivasi pasien dan keluarga untuk berserah diri kepada Tuhan (Duffy, 2018).

C. Paradigma Keperawatan Menurut Watson

Paradigma keperawatan menurut *Theory of Human Caring* Jean Watson membentuk fondasi filosofis yang kuat dalam praktik keperawatan modern yang humanistik. Empat pilar utama yaitu kemanusiaan, kesehatan, keperawatan, dan lingkungan saling terkait dalam menciptakan hubungan transpersonal yang mendalam antara perawat dan pasien.

Pendekatan ini menggeser paradigma keperawatan dari sekadar *task-oriented* menuju *person-centered*, yang menekankan bahwa caring bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana dan dengan niat apa tindakan tersebut diberikan. Berikut penjelasan paradigma keperawatan menurut Watson (Alligood, 2021):

1. Kemanusiaan

Jean Watson dengan *Theory of Human Caring* menempatkan kemanusiaan sebagai pilar utama dalam praktik keperawatan. Ia memandang manusia sebagai kesatuan utuh dari pikiran (mind), tubuh (body), jiwa (spirit), dan hubungan dengan alam. Pandangan ini menolak pendekatan yang hanya menekankan aspek biologis atau fisik, dan sebaliknya menekankan perlunya melihat pasien secara holistik, sebagai makhluk yang memiliki dimensi emosional, spiritual, sosial, dan fisik yang saling berhubungan dan saling memengaruhi.

Watson menekankan bahwa setiap manusia adalah makhluk yang unik dan bermartabat yang tidak hanya membutuhkan pengobatan atas penyakitnya, tetapi juga pengakuan terhadap nilai, harapan, dan pengalaman hidupnya. Kemanusiaan dalam konteks ini berarti mengakui keunikan setiap individu, menghormati hak-haknya, dan memberikan pelayanan keperawatan dengan penuh empati, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabatnya sebagai manusia.

Hubungan perawat-pasien harus dibangun atas dasar kepercayaan dan respek, dimana perawat tidak hanya sebagai pelaksana tindakan medis, tetapi juga sebagai mitra dalam perjalanan penyembuhan pasien, yang mendampingi, mendengarkan, dan memahami penderitaan serta harapan pasien. Perawat berperan penting dalam menciptakan lingkungan penyembuhan yang aman, penuh cinta, dan bermakna secara spiritual.

Watson juga menjelaskan bahwa aspek kemanusiaan ini harus hadir dalam setiap tindakan keperawatan, baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Sentuhan tangan, tatapan mata, kata-kata yang lembut, serta

kehadiran yang tulus dapat menjadi bentuk nyata dari *caring* yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ini memungkinkan pasien merasa didukung, dihargai, dan tidak sendirian dalam menghadapi penderitanya.

Kemanusiaan dalam teori Watson tidak hanya berlaku pada hubungan perawat dengan pasien, tetapi juga dalam hubungan antar perawat, perawat dengan keluarga pasien, dan dengan tenaga kesehatan lainnya. Prinsip dasar kemanusiaan ini menciptakan budaya kerja yang penuh hormat, kerja sama, dan solidaritas yang pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

Watson menyatakan bahwa “to care is to be human” yaitu merawat sebagai esensi dari kemanusiaan, sehingga perawat bukan hanya memberikan tindakan keperawatan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan melalui kehadirannya, tindakannya, dan cara berhubungan dengan pasien. Caring adalah cara perawat merawat pasien sebagai sesama manusia yang memiliki nilai, harapan, dan kebutuhan akan cinta dan pengakuan.

2. Kesehatan

Jean Watson tidak memaknai kesehatan sekadar sebagai ketiadaan penyakit atau gangguan fisik. Ia memandang kesehatan sebagai suatu keadaan holistik yang mencakup keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, serta hubungan yang harmonis antara individu dengan orang lain, alam, dan dimensi spiritual yang lebih besar. Kesehatan adalah suatu bentuk keutuhan eksistensial yang berakar dari kesadaran, pemaknaan hidup, dan keterbukaan terhadap perubahan.

Watson mengusulkan bahwa kesehatan merupakan suatu kesatuan energi yang terus berkembang, dimana

individu berusaha mencapai harmoni dalam berbagai aspek kehidupannya termasuk aspek fisik, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Kesehatan tidak hanya merupakan hasil, melainkan juga proses aktif pengembangan diri, pencarian makna, dan keterhubungan dengan lingkungan serta alam semesta.

Watson melihat kesehatan sebagai ekspresi dari potensi manusia untuk bertumbuh, menyembuhkan, dan mencapai aktualisasi diri melalui hubungan yang penuh kasih dan perhatian (*caring relationship*). Perawat berperan sebagai fasilitator penyembuhan, bukan hanya melalui tindakan fisik atau intervensi medis, tetapi dengan membina hubungan transpersonal yang mendorong kesadaran, penerimaan diri, dan pemaknaan terhadap pengalaman hidup.

Watson juga menekankan bahwa kesehatan dan penyakit bukanlah dikotomi yang saling bertentangan, tetapi merupakan bagian dari spektrum kehidupan yang saling melengkapi. Penyakit tidak dilihat semata-mata sebagai kegagalan biologis, melainkan sebagai gejala subjektif yang mencerminkan disharmoni dalam pikiran, tubuh, atau jiwa seseorang. Penyakit dapat menjadi undangan untuk refleksi diri, pemulihan makna hidup, serta kesempatan untuk pertumbuhan spiritual.

Ia menyatakan bahwa seseorang yang mengalami penyakit tetap bisa merasa "sehat" jika ia memiliki kedamaian batin, penerimaan, dan keterhubungan spiritual yang mendalam. Fokus perawatan tidak hanya pada "menyembuhkan penyakit", tetapi juga mendampingi individu mencapai keseimbangan batin dan pemaknaan atas pengalaman yang sedang dialaminya.

Watson juga memperkenalkan konsep medan energi manusia-lingkungan yang saling memengaruhi satu sama lain. Kesehatan dipandang sebagai hasil dari resonansi energi yang positif antara individu dan lingkungannya, termasuk dalam konteks hubungan sosial, suasana tempat tinggal, dan nilai-nilai budaya atau spiritual yang dianut. Perawat harus menciptakan lingkungan penyembuhan yang mendukung keharmonisan energi tersebut misalnya dengan komunikasi yang penuh empati, ruang perawatan yang nyaman, dan kehadiran yang menenangkan.

Kesehatan dalam paradigma ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang kemampuan untuk mencintai, memberi makna, dan menjalin hubungan yang bermakna dengan dunia sekitar. Pemahaman ini menjadi dasar untuk memberikan asuhan keperawatan yang tidak hanya menyentuh fisik pasien, tetapi juga memperhatikan dimensi batin dan eksistensialnya.

3. Keperawatan

Jean Watson mengungkapkan bahwa keperawatan bukan sekadar profesi yang memberikan intervensi medis atau memenuhi kebutuhan fisik pasien, melainkan merupakan suatu *human science* dan *art* yang melibatkan dimensi spiritual, emosional, dan eksistensial dalam proses penyembuhan. Keperawatan adalah suatu bentuk hubungan transpersonal caring yaitu hubungan antara perawat dan klien yang didasarkan pada kasih sayang, empati, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran spiritual.

Watson menekankan bahwa keperawatan adalah proses interaktif dan saling menguatkan antara perawat dan klien. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi

merupakan bentuk penyatuan energi antara dua individu yang terlibat secara mendalam dalam proses penyembuhan. Perawat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual, sehingga kehadiran perawat menjadi penyembuh (healing presence) bagi pasien.

Keperawatan menurut Watson bertujuan untuk membantu klien mencapai harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa, serta membangkitkan potensi untuk:

- a. Self-knowledge (pengetahuan diri): pasien dibantu untuk memahami kondisi dirinya secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun spiritual.
- b. Self-control (pengendalian diri): pasien memperoleh kekuatan untuk mengendalikan respons emosional atau perilaku terhadap penyakit atau situasi krisis.
- c. Self-care (perawatan diri): pasien diberdayakan untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan, bukan sekadar sebagai objek intervensi.
- d. Self-healing (penyembuhan diri): pasien dibantu menciptakan kondisi batin dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya penyembuhan secara alami.

Watson menekankan bahwa keperawatan bersifat integratif, yaitu menggabungkan ilmu biomedis, ilmu perilaku, spiritualitas, seni komunikasi, dan pemahaman nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan keperawatan. Keperawatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan (*curing*), tetapi lebih luas lagi yaitu mendukung proses penyembuhan yang bermakna (*healing*) melalui pendekatan yang humanis dan holistik.

4. Lingkungan

Jean Watson menjelaskan bahwa lingkungan tidak

hanya dipahami sebagai tempat fisik tempat perawatan berlangsung, tetapi juga mencakup dimensi mental, emosional, sosial, dan spiritual yang memengaruhi proses penyembuhan pasien. Watson menyatakan bahwa lingkungan yang mendukung, protektif, dan korektif sangat penting untuk memperkuat praktik caring dalam keperawatan.

Watson menekankan bahwa perawat memiliki peran sentral dalam menciptakan ruang penyembuhan (*healing space*) bagi pasien. Ini berarti bahwa setiap interaksi, kata, tindakan, bahkan kehadiran diam seorang perawat, bisa menjadi bagian dari suasana yang memperkuat kenyamanan, keamanan, dan harapan bagi pasien. Lingkungan yang dimaksud Watson mencakup:

- a. Lingkungan fisik: Kondisi ruangan seperti pencahayaan, suhu, kebersihan, suara, dan kenyamanan tempat tidur yang dapat mendukung istirahat dan ketenangan pasien.
- b. Lingkungan emosional: Suasana yang mencerminkan empati, penghargaan terhadap martabat pasien, rasa hormat, dan sikap tidak menghakimi.
- c. Lingkungan sosial: Hubungan yang harmonis antara pasien dengan keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas sekitar yang dapat memberi dukungan sosial dan emosional.
- d. Lingkungan spiritual: Suasana yang memungkinkan pasien terhubung dengan makna hidup, harapan, dan nilai-nilai spiritual, termasuk kesempatan untuk berdoa atau bermeditasi sesuai keyakinan pasien.

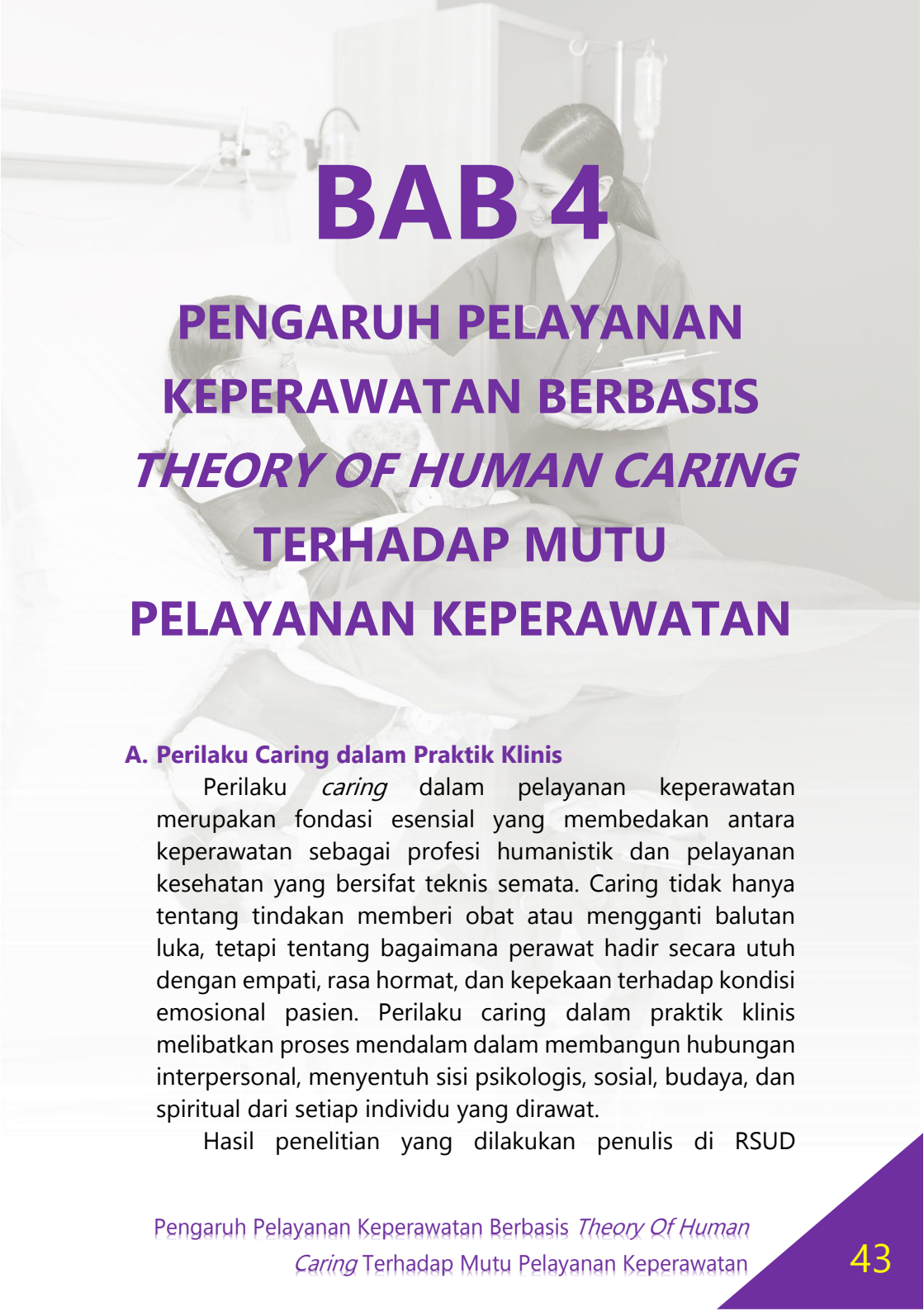
Watson menyatakan bahwa perawat membawa energi penyembuhan ke dalam lingkungan pasien melalui tindakan caring bahkan kehadiran perawat itu sendiri adalah bagian dari lingkungan penyembuhan. Saat perawat masuk ke kamar pasien, ia membawa "niat penyembuhan" (healing intention) yang dirasakan pasien sebagai bentuk harapan, kenyamanan, dan kepedulian. Ini sejalan dengan kutipan Watson: *"Ketika perawat memasuki kamar pasien, ia membawa harapan kepada pasien"*. Perawat didorong untuk secara sadar menciptakan lingkungan yang tenang, damai, dan penuh kasih. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya:

- a. Menyapa pasien dengan lembut dan penuh empati,
- b. menjaga nada suara tetap menenangkan,
- c. menjaga privasi dan kenyamanan pasien,
- d. mengatur ruangan agar bebas dari kebisingan dan gangguan,
- e. menciptakan rasa aman dan terlindungi melalui sentuhan yang penuh kasih.

Watson juga menekankan pentingnya hubungan terapeutik antara perawat dan pasien sebagai bagian dari lingkungan penyembuhan. Perawat hadir bukan sebagai orang yang superior atau sekadar "pemberi perintah", tetapi sebagai mitra sejajar yang terlibat dalam pengalaman penyembuhan pasien. Hubungan yang otentik, hangat, dan penuh perhatian inilah yang menjadi jembatan antara kebutuhan pasien dan terciptanya perubahan positif dalam diri mereka.

Watson percaya bahwa lingkungan yang penuh caring memungkinkan pasien mengalami transformasi tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga memperoleh

ketenangan batin, pencerahan makna hidup, dan kekuatan spiritual untuk menghadapi situasi sakit yang mereka alami. Lingkungan menjadi katalis dalam proses penyembuhan holistik, dimana penyembuhan terjadi bukan hanya melalui obat atau intervensi medis, tetapi melalui suasana hati, energi, dan hubungan manusiawi yang terbentuk di ruang perawatan.

A background image showing a nurse in a hospital setting, wearing a stethoscope and holding a clipboard, attending to a patient lying in a bed. The scene is dimly lit, with medical equipment visible in the background.

BAB 4

PENGARUH PELAYANAN KEPERAWATAN BERBASIS *THEORY OF HUMAN CARING* TERHADAP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

A. Perilaku *Caring* dalam Praktik Klinis

Perilaku *caring* dalam pelayanan keperawatan merupakan fondasi esensial yang membedakan antara keperawatan sebagai profesi humanistik dan pelayanan kesehatan yang bersifat teknis semata. *Caring* tidak hanya tentang tindakan memberi obat atau mengganti balutan luka, tetapi tentang bagaimana perawat hadir secara utuh dengan empati, rasa hormat, dan kepekaan terhadap kondisi emosional pasien. Perilaku *caring* dalam praktik klinis melibatkan proses mendalam dalam membangun hubungan interpersonal, menyentuh sisi psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dari setiap individu yang dirawat.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di RSUD

Kabupaten Raja Ampat menunjukkan bahwa implementasi perilaku caring belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data dari 62 responden pada kelompok kontrol didapatkan bahwa mutu pelayanan keperawatan dinilai dengan skor minimum 40 dan maksimum 90 (skor maksimal 105) dengan nilai median sebesar 60 dan simpangan baku 9,148. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pasien belum merasakan pengalaman perawatan yang sepenuhnya bermutu dari sisi keperawatan. Nilai median yang tergolong sedang ke arah rendah mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan pasien terhadap layanan yang humanis dan realitas pelayanan yang diterima, yang cenderung masih bersifat prosedural dan teknis.

Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan teori Jean Watson tentang Human Caring yang menempatkan aspek spiritual dan emosional pasien sebagai inti dari pelayanan keperawatan. Caring adalah inti dari praktik keperawatan yang sejati praktik yang tidak hanya menyembuhkan tubuh tetapi juga menyentuh jiwa. Ketika interaksi perawat-pasien tidak menyertakan kehadiran empatik dan komunikasi penuh makna, pelayanan akan terasa hambar, tidak berkesan, dan bahkan menimbulkan kecemasan atau perasaan diabaikan. Inilah yang dapat menyebabkan rendahnya persepsi pasien terhadap mutu layanan keperawatan, meskipun dari sisi teknis, tindakan sudah dilakukan secara benar (Afonso, Padilha, Neves, Elizondo, & Vieira, 2024).

Teori ini juga berkelindan dengan gagasan dari Peplau yang menyatakan bahwa hubungan interpersonal dalam keperawatan bersifat terapeutik dan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap proses penyembuhan. Relasi yang terbentuk antara perawat dan pasien bukan sekadar

interaksi fungsional, melainkan ruang penyembuhan emosional dan psikologis. Ketika hubungan ini tidak terbangun secara bermakna, pasien akan merasa menjadi objek prosedur medis semata bukan sebagai manusia yang sedang berjuang menghadapi penyakit (Hall & Shearer, 2025).

Teori Keperawatan Transkultural dari Madeleine Leininger menambahkan dimensi budaya dalam pendekatan caring. Negara Indonesia yang sangat kaya akan keragaman etnis dan keyakinan memerlukan pelayanan keperawatan yang mampu beradaptasi dengan latar belakang budaya pasien. Leininger menekankan bahwa pelayanan yang tidak sensitif terhadap budaya dapat menimbulkan resistensi, ketidaknyamanan, bahkan kegagalan dalam proses pemulihan pasien. Perilaku caring juga mencakup kemampuan perawat dalam memahami, menerima, dan menghargai nilai-nilai unik yang dipegang oleh setiap pasien (Giger & Haddad, 2021).

Berbagai studi mendukung pentingnya peran caring dalam pelayanan keperawatan yang bermutu. Darvishpour & Mahdavi Fashtami tahun 2023 menemukan bahwa ketidakterapan prinsip caring secara menyeluruh menyebabkan banyak pasien merasa pelayanan yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi nilai pribadi dan sosial-budaya mereka. Hammouri et al tahun 2024 juga menyoroti bahwa salah satu indikator utama dalam pelayanan keperawatan yang berkualitas adalah kemampuan perawat dalam menjalankan komunikasi terapeutik yang terbuka, empatik, dan menghormati perasaan pasien. Dalam hal ini, komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi medis, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan rasa dihargai dan dipahami.

Wieke Noviyanti et al tahun 2021 dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pelayanan keperawatan yang hanya menekankan prosedur teknis dan mengabaikan aspek hubungan interpersonal, cenderung dinilai buruk oleh pasien. Perasaan diabaikan, tidak dihormati, atau sekadar menjadi "pasien kamar nomor sekian" sering kali muncul ketika perawat gagal membangun kedekatan emosional yang manusiawi. Di sinilah letak pentingnya kemampuan perawat untuk mengintegrasikan nilai-nilai caring dalam setiap aspek pelayanan, baik pada saat intervensi, observasi, maupun dalam interaksi informal sehari-hari.

Rendahnya skor mutu pelayanan pada kelompok kontrol dalam penelitian ini diduga berkaitan erat dengan belum diterapkannya pendekatan caring secara sistematis dan menyeluruh. Pelayanan yang dilakukan masih cenderung prosedural, mekanistik, dan terfokus pada target teknis. Perawat mungkin sudah menjalankan standar prosedur operasi (SPO), tetapi belum menghadirkan *presence* yang hangat dan suportif di mata pasien, sehingga interaksi keperawatan terasa kaku, formal, dan minim makna, terutama dalam situasi rawat inap jangka panjang di mana kenyamanan emosional dan psikologis sangat dibutuhkan.

Asumsi yang dapat dikembangkan adalah bahwa pendekatan keperawatan yang belum didasari nilai-nilai caring mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi bervariasi, tergantung pada kepribadian dan gaya komunikasi masing-masing perawat. Tanpa standar pendekatan berbasis humanistik yang diterapkan secara institusional, mutu pelayanan akan rentan terhadap subjektivitas dan inkonsistensi. Hal ini berimplikasi serius terhadap pengalaman pasien selama menjalani perawatan, baik dari segi kenyamanan, kepercayaan, maupun kepuasan

keseluruhan terhadap rumah sakit.

Untuk itu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperkuat dimensi caring dalam sistem pelayanan keperawatan melalui pelatihan intensif soft skills, pengembangan budaya kerja humanistik, supervisi berbasis refleksi etis, serta revisi kurikulum pelatihan keperawatan yang mengintegrasikan teori caring, komunikasi terapeutik, dan kepekaan budaya. Penerapan nilai-nilai ini juga perlu difasilitasi dalam bentuk kebijakan institusi, termasuk dalam proses rekrutmen, evaluasi kinerja, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan. Beban kerja perawat yang tinggi, keterbatasan waktu, dan kurangnya ruang untuk refleksi praktik sering kali menjadi penghambat munculnya perilaku caring yang ideal. Pendekatan sistemik diperlukan agar lingkungan kerja mendukung praktik keperawatan yang penuh empati dan makna. Manajemen rumah sakit perlu menyadari bahwa investasi pada kualitas interpersonal pelayanan keperawatan sama pentingnya dengan investasi pada alat medis dan teknologi. Pada akhirnya yang paling diingat oleh pasien bukanlah seberapa canggih alat yang digunakan, tetapi seberapa dalam mereka merasa didengar, dipahami, dan diperhatikan selama menjalani perawatan.

B. Pelayanan Keperawatan Berbasis Theory of Human Caring

Pelayanan keperawatan merupakan inti dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien secara menyeluruh. Upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang berfokus pada pasien, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek teknis dan prosedural, tetapi juga mencakup aspek humanistik dan

empatik dalam praktik keperawatan sehari-hari.

1. Pengkajian

Teori Human Caring Jean Watson menerangkan bahwa proses pengkajian bukan hanya proses mengumpulkan data objektif sebagaimana pada pendekatan biomedis tradisional, tetapi merupakan interaksi transpersonal yang memungkinkan perawat dan pasien saling terhubung secara mendalam pada level emosional, sosial, kultural, dan spiritual. Hal ini mencerminkan paradigma keperawatan yang humanistik dan transpersonal, di mana manusia dipandang sebagai makhluk utuh yang terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa.

a. Tujuan Pengkajian

Tujuan utama pengkajian dalam perspektif Watson adalah untuk memahami makna dari pengalaman sakit pasien, bukan hanya mengenali gejala klinis. Oleh karena itu, pengkajian diarahkan untuk:

- 1) Memahami kondisi fisik pasien secara holistik
- 2) Menyelami perasaan, kecemasan, harapan, dan keyakinan pasien
- 3) Menemukan nilai-nilai pribadi dan spiritual pasien
- 4) Membangun hubungan kepercayaan dan menciptakan ruang penyembuhan

b. Pendekatan Caring dalam Pengkajian

Perawat harus menghadirkan dirinya secara autentik saat mengkaji pasien, artinya hadir secara utuh dengan kesadaran penuh (*mindfulness*), empati, serta tanpa menghakimi. Penggunaan bahasa tubuh yang lembut, kontak mata, sentuhan terapeutik, serta komunikasi yang hangat sangat penting untuk menciptakan koneksi yang aman dan mendukung pasien membuka diri. Watson percaya bahwa pengkajian yang dilakukan

dalam suasana caring moment yaitu momen kehadiran sejati perawat akan membuka ruang untuk transformasi penyembuhan yang lebih dalam.

c. Dimensi Kebutuhan Pasien menurut Watson

Pengkajian mencakup hirarki kebutuhan manusia yang diklasifikasikan Watson berdasarkan *inspirasi dari Maslow*, namun dengan pendekatan caring dan makna spiritual. Watson membagi kebutuhan pasien ke dalam empat kategori berikut:

1) *Lower Order Needs (Biophysical Needs)*

Kebutuhan Dasar Fisiologis ialah kebutuhan biologis yang paling mendasar agar pasien tetap hidup dan sehat. Kebutuhan ini meliputi:

- a) Nutrisi: kebutuhan makan dan minum yang seimbang dan sesuai kondisi pasien
- b) Cairan tubuh: keseimbangan cairan, hidrasi, dan tanda vital terkait
- c) Eliminasi: buang air besar dan kecil, termasuk kelancaran fungsi ginjal dan pencernaan
- d) Oksigenisasi: kebutuhan akan udara bersih, pernapasan lancar, saturasi oksigen memadai

2) *Lower Order Needs (Psychophysical Needs)*

Setelah kebutuhan biologis terpenuhi, pasien membutuhkan pemenuhan aspek kenyamanan dan fungsi tubuh, termasuk:

- a) Aktivitas: gerak tubuh, mobilisasi, atau senam pernapasan
- b) Rasa aman dan nyaman: bebas dari rasa takut, nyeri, trauma, dan cemas
- c) Seksualitas dan keutuhan tubuh: pengakuan terhadap identitas gender, privasi, dan penghormatan terhadap tubuh pasien

Perawat perlu menghargai otonomi dan privasi pasien dalam mengkaji dan memenuhi kebutuhan ini. Caring perawat tercermin dari upaya menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, dan tidak mengancam.

3) *Higher Order Needs (Psychosocial Needs)*

Kebutuhan ini berkaitan dengan hubungan sosial, harga diri, dan penghargaan diri, seperti:

- a) Afiliatif: rasa memiliki dan terhubung dengan orang lain, keluarga, sahabat, atau tim kesehatan
- b) Penghargaan: merasa dihargai, dipahami, dan diterima apa adanya
- c) Penguatan peran sosial: membantu pasien mempertahankan atau mengembalikan peran sosialnya dalam keluarga atau masyarakat

Perawat berperan sebagai pendamping dan pemberi semangat, bukan hanya pelaksana tindakan. Intervensi keperawatan harus memperkuat martabat dan identitas diri pasien, bukan melemahkannya.

4) *Higher Order Needs (Intrapersonal Needs)*

Kebutuhan Spiritual dan Aktualisasi Diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi dalam pendekatan caring, yaitu:

- a) Makna hidup dan pengalaman sakit: bagaimana pasien memaknai penderitaannya
- b) Hubungan dengan Tuhan atau kekuatan spiritual: ibadah, doa, dan dukungan iman
- c) Aktualisasi diri: keinginan untuk sembuh, harapan, cita-cita, dan rencana hidup setelah sembuh

Perawat perlu peka terhadap keyakinan spiritual pasien serta memberikan ruang untuk ekspresi religius. Caring dalam konteks ini adalah menghormati dan mendukung pertumbuhan pribadi pasien, termasuk saat mereka mengalami penderitaan atau menghadapi kematian.

- d. Peran Perawat sebagai Mitra dalam Caring Assessment
Perawat tidak lagi dipandang sebagai *expert* tunggal, melainkan sebagai mitra penyembuh yang mendengarkan, mengajak pasien berdiskusi, dan menghormati pilihan pasien. Pengkajian bukan hanya dilakukan melalui observasi dan wawancara, tetapi juga dengan kehadiran penuh kasih dan kesediaan mendengarkan dengan hati.

Watson menyebut hal ini sebagai *carative factor* pertama, yaitu *"the formation of a humanistic-altruistic system of values"*. Proses pengkajian harus dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, kasih sayang, dan pelayanan yang tulus.

2. Penentuan Diagnosa

Teori Human Caring Jean Watson, penentuan diagnosa bukan sekadar proses klinis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan fisik, melainkan sebuah langkah holistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk utuh dengan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Diagnosa keperawatan dalam konteks ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman personal pasien, perasaan, nilai-nilai, harapan, serta makna di balik penderitaan yang dialaminya. Perawat tidak hanya mencatat gejala yang tampak, tetapi juga menelaah bagaimana pasien memaknai kondisi kesehatannya.

Watson menekankan bahwa diagnosis merupakan hasil dari hubungan empatik antara perawat dan pasien, yang terjalin melalui komunikasi yang tulus dan keterbukaan. Diagnosis yang bersumber dari proses caring ini bersifat transpersonal, artinya melampaui interaksi biasa dan menjangkau kedalaman pengalaman

emosional serta spiritual pasien. Oleh karena itu, proses ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru atau hanya berdasarkan data teknis, tetapi memerlukan kehadiran penuh perhatian dari perawat serta keterlibatan aktif pasien dalam mengungkapkan apa yang dirasakan dan dibutuhkan.

Jenis diagnosa dalam pendekatan caring tidak hanya mencakup masalah fisik seperti nyeri, ketidakseimbangan nutrisi, atau gangguan pernapasan, tetapi juga masalah psikososial seperti kecemasan, kesepian, kehilangan harapan, hingga distres spiritual. Kondisi emosional atau spiritual ini justru memiliki dampak yang lebih besar terhadap kualitas hidup pasien dibanding gejala fisik itu sendiri. Perawat dituntut untuk mampu mengidentifikasi sinyal-sinyal nonverbal, bahasa tubuh, dan ungkapan perasaan yang kadang tidak langsung diutarakan oleh pasien.

Diagnosa keperawatan yang dibuat dengan pendekatan caring lebih bersifat personal dan kontekstual, misalnya, dari pada hanya menuliskan "pasien mengalami nyeri kronik," perawat dapat menyatakan bahwa "pasien mengungkapkan rasa nyeri yang telah lama dirasakan sebagai beban yang mempengaruhi harapan dan semangat hidupnya." Penggunaan bahasa yang reflektif dan penuh empati seperti ini, diagnosis menjadi lebih bermakna dan bisa menjadi dasar untuk intervensi yang menyentuh aspek terdalam kehidupan pasien.

Penetapan diagnosa yang berlandaskan pada prinsip caring juga berarti menghargai martabat pasien dalam segala situasi, termasuk ketika ia merasa putus asa, malu, atau takut. Perawat hadir untuk menerima seluruh

ekspresi emosi pasien baik positif maupun negatif tanpa menghakimi. Perawat menciptakan ruang aman bagi pasien untuk berbagi, sehingga diagnosis yang muncul merupakan hasil dari proses yang menghormati subjektivitas pasien.

Prinsip-prinsip caritas Jean Watson seperti pengembangan hubungan yang saling percaya, mendengarkan secara aktif, serta keterbukaan terhadap ekspresi spiritual pasien, menjadi fondasi penting dalam penentuan diagnosa. Diagnosis tidak lagi dilihat sebagai "produk medis" semata, tetapi sebagai hasil dari proses keperawatan yang bersifat humanistik, relasional, dan transformatif. Hal ini menjadi pembeda mendasar antara keperawatan berbasis caring dengan praktik keperawatan yang hanya berorientasi pada data klinis.

3. Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi keperawatan dalam kerangka teori Jean Watson bukan hanya aktivitas teknis yang bertujuan menyusun daftar tindakan keperawatan, melainkan sebuah proses spiritual dan intelektual yang mendalam. Perencanaan ini bertolak dari pemahaman menyeluruh terhadap kondisi pasien, baik secara fisik maupun non-fisik. Perencanaan intervensi dalam praktik caring merupakan kelanjutan dari pengkajian dan diagnosis yang dilakukan secara empatik, penuh makna, dan berbasis pada hubungan transpersonal antara perawat dan pasien.

Proses perencanaan berfokus pada identifikasi kebutuhan pasien secara holistik, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Dalam konteks ini, perawat harus mampu menghubungkan data yang dikumpulkan dengan teori caring dan menentukan

langkah-langkah keperawatan yang bukan hanya efektif secara klinis, tetapi juga memberikan rasa dihargai, dihormati, dan dicintai bagi pasien. Intervensi yang direncanakan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk menyembuhkan gejala, tetapi juga untuk menciptakan ruang penyembuhan yang memulihkan harmoni batin pasien.

Watson menekankan pentingnya keterlibatan pasien dalam proses perencanaan intervensi. Pasien diposisikan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif, dalam proses keperawatan. Perawat perlu melakukan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif agar intervensi yang direncanakan sesuai dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan tujuan hidup pasien. Ini sejalan dengan prinsip caritas: memperhatikan kebutuhan dan pengalaman unik setiap individu serta menghormati pilihan hidup mereka.

Perencanaan intervensi juga mencakup aspek edukatif dan suportif. Perawat merancang langkah-langkah edukasi kesehatan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien, serta intervensi dukungan emosional untuk membantu pasien mengelola stres, kecemasan, atau kesedihan yang mungkin timbul akibat penyakit atau situasi rawat inap. Intervensi tersebut dapat berupa terapi komunikasi, refleksi spiritual, atau penciptaan lingkungan penyembuhan yang nyaman dan aman.

Selain menyusun daftar intervensi spesifik, perawat juga menentukan indikator keberhasilan dari setiap tindakan yang direncanakan. Ini melibatkan pemilihan metode evaluasi yang sesuai dengan konteks caring, seperti pengamatan terhadap perubahan suasana hati, tingkat kenyamanan, dan kemampuan pasien dalam

melakukan self-care atau menunjukkan harapan baru. Perencanaan menjadi instrumen untuk mengevaluasi efektivitas proses caring secara komprehensif.

Perencanaan juga merujuk pada bagaimana variabel caring diukur dan diuji. Ini termasuk desain konseptual, metode pengumpulan data, siapa yang menjadi responden, dan bagaimana data dianalisis. Peneliti keperawatan yang menggunakan teori Watson akan memilih metode yang menghargai subjektivitas, misalnya studi kualitatif, naratif, atau fenomenologis, karena hal ini sejalan dengan makna dan pengalaman personal pasien.

Keseluruhan proses perencanaan ini memperkuat posisi perawat sebagai fasilitator penyembuhan yang berlandaskan kasih sayang (love), kehadiran (presence), dan perhatian (attention). Intervensi yang dirancang dari hati akan menjangkau hati pasien pula. Perencanaan bukan sekadar strategi tindakan, tetapi sebuah proses spiritual yang menghormati kehidupan dan martabat manusia.

4. Implementasi Tindakan Keperawatan

Implementasi tindakan keperawatan merupakan tahap di mana perawat melaksanakan intervensi yang telah direncanakan berdasarkan hasil pengkajian dan diagnosis. Jean Watson melalui *Theory of Human Caring* menjelaskan bahwa implementasi tidak sekadar dilakukan secara teknis atau mekanis, melainkan mengandung unsur spiritualitas, kehadiran penuh, dan koneksi antarmanusia yang mendalam. Perawat tidak hanya melakukan tindakan "kepada" pasien, tetapi hadir "bersama" pasien, menciptakan ruang penyembuhan yang penuh kasih sayang (*loving-kindness*).

Implementasi tindakan keperawatan dalam Theory of Human Caring adalah manifestasi nyata dari seni merawat yang memadukan ilmu, etika, dan spiritualitas. Perawat menjadi perpanjangan tangan kasih sayang dalam sistem pelayanan kesehatan, bukan hanya sebagai pelaksana prosedur medis, tetapi juga sebagai penyembuh jiwa yang hadir dengan kehangatan dan keikhlasan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pasien, tetapi juga memberikan makna yang dalam bagi profesi keperawatan itu sendiri.

Setiap tindakan keperawatan harus dilakukan dengan empati yang tulus, memperhatikan bukan hanya kondisi fisik tetapi juga kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual pasien, misalnya, saat memberikan injeksi atau mengganti balutan luka, perawat memperhatikan ekspresi wajah pasien, berbicara dengan nada yang menenangkan, dan memastikan bahwa pasien merasa aman serta dihormati. Hal ini menggambarkan pelaksanaan caring moments, yaitu momen interaksi yang bermakna dan dapat membentuk hubungan transpersonal antara perawat dan pasien.

Watson menekankan bahwa presence atau kehadiran terapeutik perawat menjadi kunci utama dalam implementasi tindakan caring. Kehadiran terapeutik artinya perawat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Perawat yang benar-benar hadir akan lebih peka terhadap isyarat verbal dan nonverbal pasien, serta mampu merespon secara reflektif dan penuh perhatian. Tindakan seperti menyentuh tangan pasien dengan lembut atau hanya duduk diam mendampingi pasien dapat menjadi bentuk intervensi yang sangat bermakna.

Implementasi juga mencakup kemampuan perawat dalam menciptakan lingkungan penyembuhan yang mendukung proses pemulihan holistik pasien. Ruang perawatan yang bersih, nyaman, tenang, dan penuh perhatian akan memperkuat proses penyembuhan. Lingkungan yang mendukung dapat mencakup pencahayaan yang hangat, musik lembut, aroma yang menenangkan, atau bahkan kehadiran keluarga pasien. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspek lingkungan ini selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan pasien.

Teknik-teknik caring Watson seperti menunjukkan penghargaan terhadap martabat pasien, menggunakan bahasa yang menyemangati, serta menghargai keberagaman budaya dan keyakinan pasien sangat penting, misalnya, jika pasien meminta didoakan atau mendengarkan musik religius tertentu, perawat yang caring akan menghormati permintaan tersebut sebagai bagian dari asuhan keperawatan yang holistik dan spiritual. Implementasi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai etika dalam keperawatan, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Tindakan keperawatan harus dilakukan dengan integritas tinggi, tidak hanya berdasarkan standar prosedur tetapi juga disertai dengan kesadaran moral.

5. Evaluasi Tindakan Keperawatan

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan, namun dalam *Theory of Human Caring* Jean Watson dijelaskan bahwa evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan tindakan keperawatan secara klinis, melainkan juga memperhatikan aspek spiritual, emosional, dan psikososial pasien. Evaluasi tidak

dilakukan secara kaku dan hanya berdasarkan angka atau indikator medis, tetapi lebih pada pemahaman holistik terhadap pengalaman penyembuhan pasien.

Perawat mengevaluasi sejauh mana intervensi yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dasar pasien, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan afiliasi, penghargaan, dan aktualisasi diri, misalnya, seorang pasien mungkin menunjukkan peningkatan tanda vital dan status fisik yang stabil, namun perawat caring akan melangkah lebih jauh dengan mengevaluasi apakah pasien merasa dihargai, merasa memiliki harapan, atau merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Aspek-aspek ini adalah bagian integral dari kesejahteraan pasien dalam pandangan Watson.

Evaluasi juga mencakup refleksi perawat terhadap proses caring yang telah dilakukan. Perawat perlu menilai apakah interaksi yang dibangun sudah menciptakan caring moment yang mendalam, apakah pasien merasakan kehadiran penuh dari perawat, dan apakah tindakan keperawatan dilandasi dengan ketulusan dan kasih sayang. Evaluasi bukan hanya terhadap hasil yang dicapai, tetapi juga terhadap proses hubungan antara perawat dan pasien selama proses perawatan berlangsung.

Hasil evaluasi dapat menunjukkan keberhasilan, sebagian keberhasilan, atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan keperawatan. Kegagalan tidak dilihat secara negatif, tetapi sebagai peluang untuk menyusun kembali pendekatan yang lebih manusiawi dan personal, misalnya, jika pasien menunjukkan kecemasan yang meningkat meskipun kondisi medisnya membaik, perawat dapat mengevaluasi ulang strategi komunikasi,

kebutuhan spiritual pasien, atau kebutuhan akan dukungan emosional yang belum terpenuhi.

Evaluasi caring juga bersifat dinamis, artinya dilakukan secara berkelanjutan selama proses perawatan berlangsung. Perawat caring selalu bersikap terbuka terhadap perubahan kondisi dan persepsi pasien, serta bersedia menyesuaikan intervensi agar tetap relevan dengan nilai-nilai, budaya, dan preferensi pasien. Perawatan tetap bersifat individual dan menghormati martabat manusia, yang merupakan inti dari teori caring Watson.

Perawat dapat melibatkan pasien dan keluarganya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak perawatan, misalnya, melalui komunikasi terbuka, pasien bisa menyampaikan perasaannya selama dirawat, apakah merasa nyaman, dihargai, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif ini memperkuat hubungan terapeutik dan mendorong keterlibatan aktif pasien dalam proses penyembuhan. Perawat tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga meningkatkan nilai kemanusiaan dalam praktik keperawatan. Evaluasi yang dilakukan secara empatik dan reflektif memastikan bahwa asuhan keperawatan selalu berorientasi pada kebutuhan holistik pasien. Evaluasi dalam *Theory of Human Caring* menjadi jembatan penting untuk mengintegrasikan seni, ilmu, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik keperawatan sehari-hari.

C. Pengaruh Pelayanan Keperawatan Berbasis Theory of Human Caring terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan

Pelayanan keperawatan berbasis *Theory of Human Caring* terbukti memberikan dampak signifikan terhadap

mutu pelayanan yang dirasakan oleh pasien. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna pada mutu pelayanan keperawatan antara kelompok pasien yang dirawat oleh perawat yang telah mengikuti pelatihan tentang pelayanan keperawatan berbasis *Human Caring* dibandingkan dengan kelompok pasien yang dirawat oleh perawat tanpa pelatihan serupa. Skor median mutu pelayanan pada kelompok intervensi mencapai angka 91, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan median 60 pada kelompok kontrol. Perbedaan ini mencerminkan adanya peningkatan persepsi positif pasien terhadap pelayanan keperawatan setelah perawat menerapkan prinsip-prinsip caring secara konsisten.

Pendekatan *Human Caring* yang diperkenalkan oleh Jean Watson menitikberatkan pada hubungan empatik, kehadiran autentik, dan keterlibatan emosional dalam interaksi antara perawat dan pasien. Pelayanan keperawatan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian tindakan teknis, tetapi sebagai proses interaksi kemanusiaan yang memiliki makna emosional dan spiritual. Ketika perawat menerapkan nilai-nilai caring dalam praktik sehari-hari, pasien merasakan perhatian yang tulus, rasa dihargai, dan dukungan emosional yang kuat, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan serta persepsi mutu terhadap pelayanan yang mereka terima (Afonso et al., 2024).

Peningkatan mutu pelayanan ini tidak hanya relevan dalam konteks teori Watson, tetapi juga didukung oleh teori-teori keperawatan lainnya. *Theory of Interpersonal Relations* yang dikembangkan oleh Hildegard Peplau menekankan pentingnya komunikasi terapeutik dalam membangun hubungan perawat-pasien yang saling percaya. Hubungan interpersonal yang terbentuk secara mendalam

berkontribusi langsung terhadap peningkatan persepsi mutu, karena pasien merasa lebih aman, dihargai, dan dipahami (Hall & Shearer, 2025). *Roy Adaptation Model* juga memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwa intervensi caring mendukung proses adaptasi pasien terhadap penyakitnya secara lebih positif, baik secara fisik maupun psikososial (Nuuyoma, Muvumwaeni, & Chihururu, 2024).

Temuan ini juga konsisten dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Studi oleh Bagheri et al tahun 2023 mengungkapkan bahwa pelatihan berbasis caring terhadap pengasuh pasien skizofrenia secara signifikan meningkatkan sikap caring mereka, yang berpengaruh langsung pada pengalaman pasien. Implementasi nilai-nilai caring dalam pelayanan keperawatan meningkatkan persepsi positif pasien terhadap mutu layanan. Ketidakhadiran pendekatan interpersonal yang empatik seringkali menjadi penyebab ketidakpuasan pasien terhadap layanan yang diberikan.

Dukungan terhadap pentingnya integrasi *Human Caring* dalam pendidikan dan pelatihan keperawatan juga diperkuat oleh hasil telaah sistematis yang dilakukan oleh Ghanbari et al tahun 2022. Mereka merekomendasikan agar teori caring Watson dijadikan bagian integral dalam kurikulum pendidikan keperawatan di berbagai jenjang, termasuk pelatihan profesi dan pengembangan berkelanjutan. Pendekatan caring yang diinternalisasi sejak dini akan menghasilkan tenaga keperawatan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas kemanusiaan yang tinggi dalam merespons kebutuhan pasien.

Pelatihan berbasis *Human Caring* tidak hanya memberikan nilai tambah dari sisi moral dan etika profesi,

tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap persepsi mutu pelayanan yang dirasakan oleh pasien. Ketika pasien merasa bahwa mereka dirawat oleh perawat yang hadir secara utuh tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual maka akan tercipta pengalaman pelayanan yang lebih bermakna dan memuaskan. Hal ini dapat mempercepat proses penyembuhan karena meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan rasa aman pasien selama menjalani perawatan. Hal ini berdampak pada peningkatan citra dan reputasi rumah sakit sebagai penyedia layanan yang humanis dan berkualitas tinggi.

Integrasi nilai-nilai caring ke dalam praktik keperawatan juga harus didukung oleh sistem manajemen mutu yang kuat. Pelatihan caring sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi manajerial yang mencakup supervisi klinik, refleksi praktik, dokumentasi praktik caring, serta evaluasi berkala. Evaluasi ini penting untuk menjamin konsistensi implementasi nilai-nilai caring dalam berbagai situasi klinis, sehingga tidak hanya menjadi slogan atau teori semata, melainkan benar-benar tercermin dalam tindakan keperawatan sehari-hari.

Penguatan aspek interpersonal, empatik, dan kultural dalam pelayanan, pendekatan *Human Caring* menunjukkan bahwa aspek-aspek nonteknis dalam keperawatan justru memiliki pengaruh besar terhadap persepsi mutu layanan. Perawat yang terlatih secara caring lebih peka terhadap kebutuhan emosional pasien, lebih mampu menciptakan kehadiran terapeutik yang mendalam, serta dapat membangun hubungan yang mendukung proses penyembuhan secara holistik. Strategi peningkatan mutu keperawatan yang berkelanjutan sangat dianjurkan untuk mengintegrasikan pelatihan dan supervisi caring sebagai

pendekatan utama dalam pemberian asuhan.

Theory of Human Caring bukan hanya relevan sebagai landasan filosofis dalam pendidikan keperawatan, tetapi juga efektif sebagai intervensi nyata untuk meningkatkan mutu pelayanan di dunia klinis, sehingga diperlukan langkah konkret untuk menjadikan pendekatan caring sebagai bagian dari standar operasional prosedur (SOP) keperawatan, agar setiap tindakan keperawatan tidak hanya dinilai dari segi efisiensi dan hasil klinis, tetapi juga dari segi kualitas hubungan kemanusiaan yang tercipta antara perawat dan pasien.

A background image showing a female nurse in dark scrubs and a stethoscope around her neck, smiling and attending to a young girl lying in a hospital bed. The nurse is holding a clipboard. The scene is set in a hospital room with medical equipment visible in the background.

BAB 5

PENUTUP

Pelayanan keperawatan yang berlandaskan *Theory of Human Caring* bukan hanya sebuah pendekatan filosofis, melainkan telah terbukti secara empiris mampu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dirasakan oleh pasien. Hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini, terlihat secara jelas bahwa penerapan prinsip-prinsip caring memberikan dampak positif yang signifikan terhadap persepsi mutu layanan, baik dari sisi kualitas komunikasi, sikap empatik, maupun hubungan interpersonal antara perawat dan pasien.

Teori Jean Watson memandang keperawatan bukan hanya sebagai kegiatan teknis atau prosedural, melainkan sebagai tindakan kemanusiaan yang sarat dengan makna, empati, dan kasih sayang. Ketika nilai-nilai caring ini diinternalisasi dan dipraktikkan secara konsisten oleh perawat, pasien merasakan hubungan yang lebih bermakna, perhatian yang tulus, serta kehadiran perawat yang utuh baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan kepuasan pasien, tetapi juga pada terciptanya suasana penyembuhan yang lebih kondusif dan menyeluruh.

Penelitian dalam buku ini menunjukkan bahwa perawat yang mendapatkan pelatihan caring mampu meningkatkan mutu pelayanan secara signifikan dibandingkan perawat yang

belum mendapatkan pelatihan serupa. Temuan ini sejalan dengan berbagai teori keperawatan lainnya, seperti *Interpersonal Relations Theory* oleh Hildegard Peplau dan *Roy Adaptation Model*, yang juga menekankan pentingnya hubungan terapeutik, komunikasi efektif, dan dukungan terhadap adaptasi pasien. Keseluruhan pendekatan ini menggambarkan bahwa aspek-aspek nonteknis dan kemanusiaan justru menjadi penentu utama mutu pelayanan dalam konteks keperawatan modern.

Selain dari sisi klinis, penerapan *Theory of Human Caring* juga memiliki implikasi penting dalam pendidikan, manajemen, dan kebijakan keperawatan. Pendekatan caring harus diintegrasikan sejak dini, agar mahasiswa keperawatan memahami bahwa keterampilan teknis saja tidak cukup untuk memberikan asuhan yang bermutu tinggi. Pelatihan berkelanjutan tentang caring, supervisi berbasis reflektif, dan evaluasi praktik caring harus menjadi bagian integral dari sistem manajemen mutu pelayanan keperawatan.

Penguatan budaya caring di lingkungan rumah sakit, tidak hanya pasien yang mendapatkan manfaat, tetapi juga tenaga kesehatan itu sendiri. Perawat yang bekerja dalam sistem yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi, kepuasan kerja yang lebih baik, serta tingkat stres yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa *Theory of Human Caring* bukan hanya berkontribusi terhadap hasil pasien, tetapi juga terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan.

Pendekatan caring dapat berfungsi sebagai jembatan antara tuntutan profesionalisme dan sentuhan kemanusiaan yang sering kali terlupakan dalam sistem pelayanan kesehatan yang sibuk dan berorientasi pada efisiensi. Pelayanan keperawatan menjadi lebih dari sekadar pemenuhan tugas,

namun menjadi bentuk nyata dari pelayanan yang tulus dan berbelas kasih. *Theory of Human Caring* tidak hanya relevan, tetapi sangat penting untuk diadopsi secara luas di tengah dinamika dan tantangan sistem kesehatan saat ini.

Akhirnya, buku ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan keperawatan harus dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang hakikat keperawatan sebagai profesi yang melayani dengan hati dengan menjadikan *Theory of Human Caring* sebagai kerangka kerja utama, diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidik, praktisi, manajer keperawatan, dan pembuat kebijakan dapat bersinergi dalam menciptakan layanan keperawatan yang tidak hanya berkualitas secara klinis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan pasien secara utuh.

Sebagai rekomendasi akhir, penulis mendorong agar setiap institusi layanan kesehatan mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang secara eksplisit memuat nilai-nilai caring sebagai bagian dari pedoman praktik keperawatan. Implementasi caring tidak boleh berhenti pada pelatihan sesaat, tetapi harus dipelihara melalui supervisi, refleksi rutin, dokumentasi praktik caring, dan integrasi dalam penilaian kinerja perawat. Pelayanan keperawatan yang diberikan akan senantiasa berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam dan bermuara pada peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA



- Afonso, S. da R., Padilha, M. I., Neves, V. R., Elizondo, N. R., & Vieira, R. Q. (2024). Critical analysis of the scientific production on Jean Watson's Theory of Human Care. *Revista Brasileira De Enfermagem*, 77(2), e20230231. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0231>
- Akansel, N., Watson, R., Vatansever, N., & Özdemir, A. (2021). Nurses' perceptions of caring activities in nursing. *Nursing Open*, 8(1), 506–516. <https://doi.org/10.1002/nop2.653>
- Alligood, M. (2021). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Philadelphia: Elsevier, Inc.
- Arnike, G., & Kadir, A. (2022). Hubungan perilaku caring perawat dengan kepuasan pasien di Poli Umum Puskesmas Besiq Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022. *Health Information: Jurnal Penelitian*.
- Arsat, N., Lah, N. A. S. N., Thomas, D. C., Soong, S. F., Chong, L. T., Sawatan, W., ... Wider, W. (2023). The effect of work setting and demographic factors on caring behaviour among nurses in the public hospitals and public health services, Sabah, Malaysia. *BMC Nursing*, 22(1), 194. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01359-w>
- Bachtiar, A., Baua, E., & Pizarro, J. (2023). Effect of a caring-based training program on caring behaviors of Indonesian nurses as perceived by patients. *Iranian*

Journal of Nursing and Midwifery Research, 28(1), 60. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_418_21

- Bagheri, S., Zarshenas, L., Rakhshan, M., Sharif, F., Sarani, E. M., Shirazi, Z. H., & Sitzman, K. (2023). Impact of Watson's human caring-based health promotion program on caregivers of individuals with schizophrenia. *BMC Health Services Research*, 23(1), 711. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09725-9>
- Baumann, A., & Crea-Arsenio, M. (2023). The Crisis in the Nursing Labour Market: Canadian Policy Perspectives. *Healthcare*, 11(13), 1954. <https://doi.org/10.3390/healthcare11131954>
- Breneol, S., Goldberg, L., & Watson, J. (2019). Caring for children who are technology-dependent and their families: The application of watson's caring science to guide nursing practice. *Advances in Nursing Science*, 42(2), E13–E23. <https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000238>
- Darvishpour, A., & Mahdavi Fashtami, S. (2023). Investigation of Caring Behavior and Caring Burden and Their Associated Factors among Nurses Who Cared for Patients with COVID-19 in East Guilan, the North of Iran. *Nursing Research and Practice*, 2023, 1–11. <https://doi.org/10.1155/2023/8567870>
- Duffy, J. R. (2018). *Quality caring in nursing and health systems: Implications for clinicians, educators, and*

leaders (Third edition). New York: Springer Publishing Company.

- Elahi, M., Mansouri, P., & Khademian, Z. (2021). The effect of education based on human care theory on caring behaviors and job involvement of nurses in intensive care units. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 26(5), 425–429. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_43_20
- Ghanbari, A. L., Adib, H. M., & Dianati, M. (2022). Human caring: A concept analysis. *Journal of Caring Sciences*, 11(4), 246–254. <https://doi.org/10.34172/jcs.2022.21>
- Giger, J. N., & Haddad, L. G. (Eds.). (2021). *Transcultural nursing: Assessment and intervention* (Eighth edition). St. Louis, Missouri: Elsevier.
- Hall, S., & Shearer, K. (2025). Applying Peplau's Interpersonal Relations Theory to Enhance Older Adults' Health Literacy Through Nursing Care: A Theory Analysis. *Journal of Holistic Nursing*, 08980101251345027. <https://doi.org/10.1177/08980101251345027>
- Hammouri, F. A., Hamdan, K. M., Haymour, A. M., Ibrahim, M. O., Malkawi, A., Al-Hiary, S. S., ... Shaheen, A. M. (2024). Quality of nursing care: Predictors of patient satisfaction in a national sample. *Nursing Open*, 11(8), e2252. <https://doi.org/10.1002/nop2.2252>

- Nuuyoma, V., Muvumwaeni, S., & Chihururu, L. (2024). Transcultural nursing: A qualitative analysis of nursing students' experiences in a multicultural context in North-Eastern Namibia. *BMC Nursing*, 23(1), 123. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01773-8>
- Permana, B., Yusuf, Ah., Bakar, A., & Lindayani, L. (2024). Mediating effect of motivation on the relationship between lecturer experience and learning environment with caring character among Undergraduate Nursing Student in Indonesia. *SAGE Open Nursing*, 10, 23779608231226072. <https://doi.org/10.1177/23779608231226072>
- Pitkänen, V., & Linnosmaa, I. (2021). Choice, quality and patients' experience: Evidence from a Finnish physiotherapy service. *International Journal of Health Economics and Management*, 21(2), 229–245. <https://doi.org/10.1007/s10754-020-09293-z>
- Porter, O. T., Weberg, D. R., Mangold, K., & Malloch, K. (2019). *Leadership in nursing practice: Changing the landscape of health care* (Third). Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning.
- Prapitasari, R., & Jalilah, N. H. (2020). *Konsep dasar mutu pelayanan kesehatan*. Indramayu: Cv. Adanu Abimata.

- Ratna, Bau, A. S., Sawitri, N. K. A., Paulina, Ngii, Y., Mariana, D., ... Dewi, I. M. (2021). *Falsafah dan teori dalam keperawatan*. CV Eureka Media Aksara.
- Seangpraw, K., & Ong, A. P. (2020). Knowledge and behaviors toward health care for elderly patients with hypertension, and quality of life among informal caregivers in Northern Thailand. *Journal of Multidisciplinary Healthcare, Volume 13*, 1771–1780. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S284886>
- Smith, M. C., Turkel, M. C., Wolf, Z. R., & Watson Caring Science Institute (Eds.). (2013). *Caring in nursing classics: An essential resource*. New York: Springer Pub. Company.
- Susanti, M., Febrianti, L., Emrita, R., Hilmawati, H., Wahyudi, W., & Syafrida, S. (2022). The effect of caring training on the implementation of caring behavior and work culture of nurses in providing services to COVID-19 patients in an Indonesia's National Referral Hospital. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 10*(E), 655–661. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8761>
- Wang, T., Li, Y., Chen, J., Meng, A., Wang, Y., Zhang, L., ... Zhao, Y. (2024). The impact of work environment on caring behavior among Chinese hospice nurses: The chain mediating effect of psychological capital and empathy. *Frontiers in Psychology, 15*, 1348269. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1348269>

- Wieke Noviyanti, L., Ahsan, A., & Sudartya, T. S. (2021). Exploring the relationship between nurses' communication satisfaction and patient safety culture. *Journal of Public Health Research, 10*(2), 2225. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2225>
- Wuwung, E. C. Q., Gannika, L., & Karundeng, M. (2020). Perilaku caring perawat dengan kepuasan pasien. *Jurnal Keperawatan, 8*(1).

PROFIL PENULIS



Ns. Norita Marici Tetelepta, S.Kep., lahir di Doom pada tanggal 1 November 1986. Penulis merupakan seorang perawat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdedikasi di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak tahun 2011. Perjalanan karier keperawatan penulis dimulai di Puskesmas Deer, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, tempat penulis pertama kali menjalankan tugas sebagai perawat. Pada tahun 2016, penulis dipindah tugaskan ke UPT RSUD Kabupaten Raja Ampat dan dipercaya untuk bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Komitmen dan kompetensi penulis dalam memberikan pelayanan keperawatan yang optimal menghantarkan penulis untuk mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Ruangan ICU sejak tahun 2020 hingga 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024, penulis diangkat sebagai Kepala Ruangan Rawat Inap Bedah dan masih aktif menjalankan tugas tersebut hingga saat ini. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Keperawatan di STIKES Papua Sorong pada tahun 2009 dan melanjutkan Pendidikan Profesi Ners yang dituntaskan pada tahun 2010 di institusi yang sama. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman klinis yang kuat, penulis terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan yang profesional, empatik, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan di wilayah Kabupaten Raja Ampat

PROFIL PENULIS



Dr. Blacius Dedi, SKM., M.Kep.,

merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Cijoho, Tasikmalaya, kemudian melanjutkan ke jenjang SLTP di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Misi, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Pendidikan tinggi bidang keperawatan dilanjutkan di Akademi Keperawatan DepKes Pajajaran Bandung dan lulus pada tahun 1990. Penulis kemudian meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (FKM-UNDIP) Semarang pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan dengan peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) pada tahun 2008. Gelar Doktor Ilmu Keperawatan (Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Keperawatan) dari FIK UI berhasil diraih pada tahun 2012. Dalam karier profesional, penulis mengawali sebagai perawat di Rumah Sakit Misi Lebak, sebelum kemudian menekuni dunia pendidikan keperawatan. Pengalaman mengajar dimulai di SPK Misi Lebak, dilanjutkan sebagai dosen di AKPER Immanuel Bandung, dan kemudian di STIKes Immanuel Bandung. Di sana, penulis mengajar sekaligus membimbing praktik klinik untuk mahasiswa program D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners dari tahun 2000 hingga 2019. Sejak tahun 2013, penulis juga dipercaya sebagai dosen tamu (dosen luar biasa) pada program Magister

Keperawatan (peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan) di berbagai institusi, antara lain FIK Universitas Padjadjaran (UNPAD), STIKes Jenderal A. Yani Bandung, dan STIKes St. Carolus Jakarta. Pada tahun 2019, penulis bergabung sebagai dosen tetap di Universitas Karya Husada Semarang, dan sejak saat itu menjabat sebagai **Kepala Program Studi Magister Keperawatan** di institusi tersebut hingga sekarang. Selain itu, penulis juga menjadi dosen tamu pada program Magister Keperawatan – Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Penulis aktif sebagai konsultan dalam pengembangan pendidikan keperawatan di STIKes Halmahera Utara sejak tahun 2013 hingga kini. Pengalaman internasionalnya meliputi kegiatan benchmark dan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Flinders University – Adelaide, South Australia, pada tahun 2008. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar nasional dan pelatihan di bidang kepemimpinan serta manajemen keperawatan di berbagai institusi pendidikan dan rumah sakit. Pengalaman internasional lainnya termasuk benchmark dan penandatanganan MoA dengan Trinity University of Asia dan St. Luke’s Hospital di Quezon City – Manila, University of the Cordilleras – Baguio City, dan University of Baguio, Filipina. Penulis juga pernah memberikan kuliah tamu di Benguet State University dan University of the Cordilleras, serta menjadi juri (judge) dalam Seminar Internasional PNA (Philippine Nurses Association) di Baguio City, Filipina.

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Tri Ismu Pujiyanto, SKM., S.Kep., M.Kes, M.Kep., merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang kesehatan masyarakat dan keperawatan dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di dunia pendidikan tinggi kesehatan. Lahir di Batang pada tanggal 30 Mei 1969, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro pada tahun 1996. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan Magister Epidemiologi di universitas yang sama dan lulus pada tahun 2004. Komitmennya dalam pengembangan ilmu keperawatan membawanya untuk meraih gelar Magister Keperawatan dari Universitas Indonesia pada tahun 2010, serta menempuh pendidikan Doktoral Ilmu Kedokteran/Kesehatan di Universitas Diponegoro yang diselesaikan pada tahun 2018. Selain itu, beliau juga menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Muhammadiyah Kudus, masing-masing pada tahun 2021 dan 2022. Dalam karier profesionalnya, Dr. Tri Ismu Pujiyanto telah menjabat berbagai posisi strategis di institusi pendidikan tinggi. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur AKPER Karya Husada Semarang (1998–2003), Direktur AKKES Karya Husada Semarang (2003–2005), dan Ketua STIKES Karya Husada Semarang (2005–2014). Saat ini, beliau aktif sebagai Ketua Pembina sekaligus Pendiri Yayasan Perti Karya Husada Semarang sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik Universitas Karya Husada Semarang sejak tahun 2022. Beliau juga merupakan dosen tetap di Karya Husada Semarang selama lebih dari 31 tahun dengan jabatan fungsional akademik sebagai Lektor Kepala.

SINOPSIS BUKU

Pelayanan keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek klinis dan teknis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang menjadi inti dari profesi keperawatan. Theory of Human Caring yang dikembangkan oleh Jean Watson memberikan fondasi kuat bagi praktik keperawatan yang berorientasi pada kepedulian, empati, dan hubungan interpersonal antara perawat dan pasien. Pelayanan yang berlandaskan pada teori ini diyakini mampu meningkatkan mutu pelayanan secara menyeluruh, baik dari sudut pandang pasien maupun perawat itu sendiri.

Buku ini menyajikan hasil penelitian mendalam mengenai pengaruh penerapan pelayanan keperawatan berbasis Theory of Human Caring terhadap mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. Hasil penelitian ini mengkaji perbedaan mutu pelayanan sebelum dan sesudah intervensi pelatihan tentang pelayanan keperawatan berbasis caring diberikan. Selain mengukur hasil secara numerik, buku ini juga menjelaskan dimensi mutu seperti responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas pelayanan dari sudut pandang pasien maupun perawat.

Buku ini juga mengulas faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi teori caring di lapangan, termasuk aspek budaya organisasi, kepemimpinan, dan kompetensi emosional perawat. Buku ini membahas bagaimana pendekatan caring dapat menjadi strategi penting dalam membangun hubungan terapeutik, meningkatkan kepuasan pasien, serta memperkuat peran perawat sebagai penyedia layanan yang bermakna dan berdampak.

Buku ini memberikan rekomendasi praktis bagi rumah sakit, pendidik keperawatan, dan pengambil kebijakan, seperti pelatihan berkelanjutan tentang nilai-nilai caring, integrasi teori

caring ke dalam SOP keperawatan, serta penguatan budaya organisasi yang mendukung praktik berbasis kasih sayang dengan harapan adanya transformasi pelayanan keperawatan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya mutu layanan secara berkelanjutan.

Pelayanan keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek klinis dan teknis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang menjadi inti dari profesi keperawatan. Theory of Human Caring yang dikembangkan oleh Jean Watson memberikan fondasi kuat bagi praktik keperawatan yang berorientasi pada kepedulian, empati, dan hubungan interpersonal antara perawat dan pasien. Pelayanan yang berlandaskan pada teori ini diyakini mampu meningkatkan mutu pelayanan secara menyeluruh, baik dari sudut pandang pasien maupun perawat itu sendiri.

Buku ini menyajikan hasil penelitian mendalam mengenai pengaruh penerapan pelayanan keperawatan berbasis Theory of Human Caring terhadap mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. Hasil penelitian ini mengkaji perbedaan mutu pelayanan sebelum dan sesudah intervensi pelatihan tentang pelayanan keperawatan berbasis caring diberikan. Selain mengukur hasil secara numerik, buku ini juga menjelaskan dimensi mutu seperti responsiveness, assurance, tangible, empathy, dan reliability sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas pelayanan dari sudut pandang pasien maupun perawat.

Buku ini juga mengulas faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi teori caring di lapangan, termasuk aspek budaya organisasi, kepemimpinan, dan kompetensi emosional perawat. Buku ini membahas bagaimana pendekatan caring dapat menjadi strategi penting dalam membangun hubungan terapeutik, meningkatkan kepuasan pasien, serta memperkuat peran perawat sebagai penyedia layanan yang bermakna dan berdampak.

Buku ini memberikan rekomendasi praktis bagi rumah sakit, pendidik keperawatan, dan pengambil kebijakan, seperti pelatihan berkelanjutan tentang nilai-nilai caring, integrasi teori caring ke dalam SOP keperawatan, serta penguatan budaya organisasi yang mendukung praktik berbasis kasih sayang dengan harapan adanya transformasi pelayanan keperawatan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya mutu layanan secara berkelanjutan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-88-3



9

786347

294883